

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Introducción a Ginecología

Subtema: Amenorrea primaria - síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser

Caso clínico 1. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Adolescente de 16 años, deportista recreativa, sin telarquia retrasada ni enfermedades crónicas. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Nunca ha menstruado; Tanner V, talla 164 cm, vagina corta en fondo de saco ciego, útero no visible en ultrasonido y ambos ovarios con folículos. Cariotipo 46,XX; testosterona dentro del intervalo femenino. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso que integra el diagnóstico y el manejo inicial recomendado?

- A. Explicar agenesia mülleriana, solicitar evaluación renal y ofrecer dilatación vaginal progresiva como primera línea. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La combinación de caracteres sexuales secundarios normales, 46,XX, ovarios funcionales y ausencia uterovaginal corresponde a MRKH. Deben buscarse malformaciones urinarias; la dilatación es la opción inicial cuando la paciente desea canal vaginal.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de amenorrea primaria y secundaria.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Introducción a Ginecología

Subtema: Amenorrea secundaria - síndrome de Asherman

Caso clínico 2. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 31 años con antecedente de legrado por hemorragia posaborto complicada con endometritis hace 10 meses. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Presenta amenorrea secundaria, dolor pélvico cíclico mensual y prueba de embarazo negativa. TSH, prolactina y FSH son normales; tras prueba de progesterona no hay sangrado. Ultrasonido con endometrio irregular y escaso. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál prueba diagnóstica y tratamiento deben priorizarse?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Histeroscopia diagnóstica y lisis histeroscópica de adherencias, seguida de medidas para favorecer regeneración endometrial. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La amenorrea posterior a instrumentación e infección, sin sangrado por privación, orienta a sinequias intrauterinas. La histeroscopia confirma y permite tratar en el mismo acto; estudios indirectos no sustituyen la visualización directa.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de amenorrea primaria y secundaria.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Ciclo genital, esterilidad y anticonceptivos

Subtema: Infertilidad - factor tuboperitoneal

Caso clínico 3. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Paciente de 34 años con infertilidad de 18 meses, ciclos regulares y reserva ovárica conservada; su pareja tiene espermatobioscopia normal. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tuvo enfermedad pélvica inflamatoria documentada por Chlamydia y un embarazo ectópico tratado médicamente. Histerosalpingografía muestra obstrucción distal bilateral con hidrosálpinx. No hay datos de endometriosis profunda. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Qué intervención mejora de manera más clara la probabilidad de éxito antes de reproducción asistida?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Salpingectomía o exclusión tubárica bilateral del hidrosálpinx antes de fertilización in vitro. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El hidrosálpinx reduce implantación y eleva pérdidas en FIV; el manejo quirúrgico previo mejora resultados. Insistir en inducción de ovulación no corrige el factor anatómico predominante.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de la pareja infértil.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Ciclo genital, esterilidad y anticonceptivos

Subtema: Anticoncepción en puerperio

Caso clínico 4. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 38 años, día 12 posparto, lactancia exclusiva, IMC 34 kg/m² y antecedente de trombosis venosa profunda asociada a anticonceptivo combinado. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Desea evitar embarazo por al menos tres años. No fuma, no recibe anticoagulación actual y no tiene sepsis puerperal ni sangrado anormal. Pregunta por una opción altamente eficaz que no interfiera con la lactancia. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál opción es más apropiada ahora?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Implante subdérmico de etonogestrel o dispositivo intrauterino con levonorgestrel, tras consejería y exclusión de contraindicaciones locales. *

Explicación: Los métodos sólo con progestágeno y los DIU son compatibles con lactancia y evitan estrógeno, que es inadecuado temprano tras parto y con antecedente trombotico. El método combinado incrementaría el riesgo trombotico.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Planificación familiar y anticoncepción.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Sangrado uterino anormal no anatómico

Subtema: Sangrado uterino anormal por disfunción ovulatoria

Caso clínico 5. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 44 años con obesidad, oligomenorrea de años y sangrado abundante por 20 días; refiere mareo pero está hemodinámicamente estable. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Hb 8.8 g/dL, prueba de embarazo negativa, TSH normal. Ultrasonido sin lesión focal, endometrio de 15 mm. No usa anticoagulantes y su exploración no revela infección pélvica. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: Además de controlar el sangrado, ¿qué procedimiento no debe omitirse?

- A. Muestreo endometrial ambulatorio para descartar hiperplasia o cáncer de endometrio. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: Edad mayor de 40 años, anovulación crónica y obesidad implican exposición estrogénica sin oposición y obligan a evaluar endometrio. La ausencia de masa ecográfica no excluye lesión histológica.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento del sangrado uterino anormal.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Sangrado uterino anormal de origen desconocido

Subtema: Síndrome de ovario poliquístico

Caso clínico 6. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 27 años con hirsutismo progresivo, acné, ciclos cada 70 a 120 días e infertilidad de un año. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: IMC 32 kg/m²; testosterona libre elevada de forma moderada, TSH y prolactina normales, 17-hidroxiprogesterona basal no sugestiva de hiperplasia suprarrenal. Ultrasonido con ovarios poliquísticos. Desea embarazo y no hay otro factor de infertilidad. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento farmacológico de primera elección para inducir ovulación?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Letrozol, acompañado de intervención intensiva sobre peso y riesgo metabólico. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: En SOP anovulatorio con deseo gestacional, letrozol es el inductor inicial recomendado por mejores desenlaces ovulatorios y de nacido vivo frente a esquemas antiguos. La metformina no sustituye al inductor cuando la indicación es fertilidad.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento del síndrome de ovario poliquístico.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología, menopausia y climaterio

Subtema: Terapia hormonal menopáusica

Caso clínico 7. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 52 años, menopausia hace 14 meses, bochornos incapacitantes y sueño fragmentado; conserva útero. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: No tiene antecedente de cáncer de mama, tromboembolismo, hepatopatía o enfermedad cardiovascular; mastografía y presión arterial sin alteraciones. Pregunta si puede recibir hormonas porque una hermana tuvo osteoporosis. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál esquema es correcto si decide terapia hormonal tras decisión compartida?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Estrógeno sistémico a la dosis mínima eficaz combinado con progestágeno para protección endometrial. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: En mujer sintomática menor de 60 años y cercana a menopausia, sin contraindicaciones, puede considerarse terapia hormonal. Si el útero está presente debe agregarse progestágeno para evitar hiperplasia endometrial.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento del climaterio y menopausia.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Sangrado uterino anormal anatómico no maligno

Subtema: Miomatosis uterina

Caso clínico 8. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 39 años con menorragia, anemia ferropénica y deseo reproductivo inmediato; no acepta histerectomía. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Ultrasonido y sonohisterografía muestran mioma submucoso FIGO 1 de 3.5 cm que distorsiona cavidad; hay dos miomas intramurales pequeños no deformantes. Hb 9.4 g/dL tras hierro intravenoso. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál estrategia se ajusta mejor al objetivo reproductivo?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Resección histeroscópica del mioma submucoso, preservando el útero. *

Explicación: El mioma submucoso que distorsiona cavidad se vincula a sangrado e infertilidad; la histeroscopia permite retirar la lesión causal con conservación uterina. Embolización no es la opción preferida cuando se busca gestación.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de miomatosis uterina.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Oncología ginecológica

Subtema: Cáncer de endometrio

Caso clínico 9. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 61 años, posmenopáusica, con sangrado escaso recurrente, diabetes y obesidad; no usa terapia hormonal. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Ultrasonido transvaginal muestra endometrio de 8 mm. Biopsia por aspiración informa adenocarcinoma endometriode grado 1. Resonancia sin invasión miometrial profunda ni adenopatías sospechosas. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico inicial estándar?

- A. Histerectomía total con salpingooforectomía bilateral y estadificación ganglionar según riesgo, preferentemente por vía mínimamente invasiva. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El cáncer endometrial aparente temprano se trata con cirugía; la evaluación ganglionar se individualiza según riesgo. El progestágeno conservador se reserva para escenarios muy seleccionados de preservación de fertilidad.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento del cáncer de endometrio.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Oncología ginecológica

Subtema: Cáncer de ovario epitelial

Caso clínico 10. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 58 años con distensión abdominal, saciedad temprana y pérdida de 6 kg en tres meses. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Ultrasonido: masa anexial compleja bilateral, ascitis y nódulos peritoneales. CA-125 elevado; tomografía sin metástasis extraabdominal. Está funcionalmente apta para cirugía y el caso se discute con oncología ginecológica. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta ofrece el mejor enfoque inicial?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Laparotomía de estadificación y citorreducción completa por equipo oncológico, si se anticipa resección óptima. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La sospecha de cáncer epitelial avanzado requiere atención por equipo especializado y citorreducción máxima cuando es factible. La aspiración o cirugía incompleta fuera de un entorno oncológico comprometen diagnóstico y desenlace.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento del cáncer epitelial de ovario.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Oncología ginecológica

Subtema: Prevención y tamizaje de cáncer cervicouterino

Caso clínico 11. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 35 años, asintomática, inmunocompetente, sin antecedente de NIC, llega para tamizaje rutinario. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Nunca se ha realizado prueba de VPH. No está embarazada, no tiene histerectomía y su citología previa de hace siete años fue normal. Solicita la prueba con mejor estrategia de detección primaria disponible en el programa. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el estudio de elección?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Prueba de detección de VPH de alto riesgo como tamizaje primario, con triaje conforme al algoritmo nacional. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: En el grupo etario correspondiente, la prueba de VPH de alto riesgo es la estrategia primaria del programa; un resultado positivo exige triaje, no tratamiento directo. La inspección visual no reemplaza el algoritmo donde está disponible VPH.

Fuente: Secretaría de Salud/CNEGSR. Lineamientos para la prevención y detección oportuna del cáncer cervicouterino.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Oncología ginecológica

Subtema: Cáncer cervicouterino localmente avanzado

Caso clínico 12. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 46 años con sangrado poscoital y flujo fétido; biopsia confirma carcinoma escamoso cervical. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Exploración bajo anestesia y resonancia: tumor de 5 cm con invasión parametrial unilateral, sin extensión a pared pélvica; función renal conservada. PET/CT no muestra metástasis distante. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es la estrategia terapéutica de elección?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Quimiorradiación concomitante basada en cisplatino seguida de braquiterapia. *

Explicación: La invasión parametrial define enfermedad localmente avanzada en la que la cirugía radical no es el estándar. La radioterapia externa con cisplatino radiosensibilizante y braquiterapia es el tratamiento curativo recomendado.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia**Tema: Patología mamaria benigna****Subtema: Mastitis puerperal**

Caso clínico 13. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Puérpera de 19 días con fiebre, dolor focal y eritema mamario; lacta con grietas en pezón y refiere vaciamiento incompleto. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Está estable, sin fluctuación ni masa profunda; ultrasonido no muestra colección. Tiene malestar general, pero tolera vía oral y el recién nacido se alimenta con eficacia del lado contralateral. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál indicación debe incluirse de forma prioritaria?

- A. Continuar el vaciamiento frecuente de la mama afectada, corregir técnica de lactancia e iniciar antibiótico antiestafilocócico si hay mastitis bacteriana. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: Suspender lactancia favorece estasis y empeora el proceso. Sin absceso, el manejo combina vaciamiento, apoyo analgésico y antibiótico dirigido cuando el cuadro clínico es compatible con infección bacteriana.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de mastitis puerperal.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Cáncer de mama

Subtema: Lesión palpable sospechosa

Caso clínico 14. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 48 años con masa dura de 2.8 cm, retracción cutánea discreta y ganglio axilar móvil. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Mastografía BI-RADS 5 y ultrasonido con lesión irregular espiculada. No hay metástasis clínica. Solicita extirpación inmediata porque teme una biopsia que 'disemine' el tumor. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso diagnóstico correcto?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Biopsia con aguja de corte guiada por imagen, con evaluación de receptores hormonales y HER2 en el tejido tumoral. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La triple evaluación requiere confirmación histológica antes de planear cirugía y tratamiento sistémico. La biopsia con aguja permite caracterizar biología tumoral y no debe reemplazarse por cirugía diagnóstica indiscriminada.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología infecciosa cervical

Subtema: Enfermedad pélvica inflamatoria

Caso clínico 15. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 23 años, nueva pareja sexual, dolor hipogástrico bilateral de 48 horas, fiebre y dispareunia. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene dolor a movilización cervical, dolor anexial y flujo mucopurulento; prueba de embarazo negativa, sin absceso en ultrasonido. Está estable y tolera tratamiento oral. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál esquema ambulatorio cubre de manera adecuada los patógenos probables?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Ceftriaxona más doxiciclina y metronidazol, con tratamiento de parejas y abstinencia hasta completar manejo. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El umbral para tratar EPI es bajo ante dolor pélvico y sensibilidad cervical/adnexial. El esquema debe cubrir gonococo, Chlamydia y anaerobios; no debe esperarse un cultivo para iniciar tratamiento.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de enfermedad pélvica inflamatoria.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Control prenatal

Subtema: Profilaxis anti-D en paciente Rh negativa

Caso clínico 16. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Primigesta de 28 semanas, grupo O Rh negativo, Coombs indirecto negativo y pareja Rh positiva desconocida. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Control prenatal normal, sin sangrado ni procedimientos invasivos. Recibió inmunoglobulina anti-D tras aborto previo de ocho semanas hace dos años. Pregunta si debe esperar al nacimiento para recibir otra dosis. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Qué conducta es correcta?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Administrar inmunoglobulina anti-D antenatal alrededor de la semana 28 y repetir posparto si el recién nacido es Rh positivo, además de eventos sensibilizantes. *

Explicación: La profilaxis antenatal reduce sensibilización subclínica del tercer trimestre. Un antecedente de profilaxis previa no sustituye la dosis de la gestación actual ni la profilaxis tras evento fetomaterno.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Prevención, diagnóstico y tratamiento de la isoinmunización materno-fetal Rh.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Hemorragias del primer trimestre

Subtema: Embarazo ectópico no roto

Caso clínico 17. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 29 años con dolor unilateral leve y manchado escaso; antecedente de salpingitis. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Beta-hCG 2,400 mUI/mL, ultrasonido transvaginal sin saco intrauterino y masa tubárica de 1.8 cm sin actividad cardíaca; no hay líquido libre. Estable, sin hepatopatía ni lactancia, puede acudir a controles. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo más apropiado?

- A. Metotrexato sistémico con seguimiento seriado de beta-hCG, tras confirmar criterios de elegibilidad. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: En ectópico no roto, pequeño, sin actividad embrionaria y con seguimiento posible, el metotrexato evita cirugía. Debe verificarse descenso adecuado y advertirse signos de ruptura; no se administra si existen contraindicaciones.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento del embarazo ectópico.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Hemorragias del primer trimestre

Subtema: Enfermedad trofoblástica gestacional

Caso clínico 18. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 24 años con hiperemesis intensa, sangrado vaginal y útero mayor al esperado para edad gestacional. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Beta-hCG marcadamente elevada; ultrasonido muestra imagen difusa en 'tormenta de nieve' sin embrión. Presenta TSH suprimida y quistes tecaluteínicos bilaterales; no desea fertilidad inmediata. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta inicial indicada?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Evacuación uterina por aspiración, determinación basal de beta-hCG y vigilancia seriada posterior. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La mola completa se resuelve inicialmente mediante aspiración uterina, no con inducción médica. La vigilancia cuantitativa de beta-hCG permite identificar neoplasia trofoblástica persistente y exige anticoncepción confiable durante seguimiento.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de enfermedad trofoblástica gestacional.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia
Tema: Hemorragias del segundo trimestre
Subtema: Placenta previa

Caso clínico 19. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Gestante de 32 semanas, dos cesáreas previas, presenta sangrado rojo brillante indoloro de inicio súbito. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Está estable, feto reactivo. Ultrasonido transvaginal localiza placenta que cubre por completo el orificio cervical interno; no hay contracciones ni datos de desprendimiento. En urgencias se plantea tacto vaginal para 'confirmar'. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta inmediata correcta?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Evitar tacto vaginal digital, estabilizar, realizar vigilancia materno-fetal y planear nacimiento por cesárea según evolución. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: En placenta previa confirmada o sospechada, el tacto digital puede desencadenar hemorragia grave. La ecografía transvaginal es segura y precisa para ubicación placentaria; la vía de nacimiento será cesárea si persiste oclusión.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de placenta previa y acretismo placentario.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia
Tema: Hemorragias del segundo trimestre
Subtema: Acretismo placentario

Caso clínico 20. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Gestante de 35 semanas con placenta previa anterior, tres cesáreas previas y lagunas vasculares placentarias con pérdida de zona clara en ultrasonido. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Resonancia sugiere invasión profunda sin invasión vesical inequívoca. No sangra, está estable y se encuentra en hospital de referencia. La familia desea preservar el útero a toda costa. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál estrategia reduce más el riesgo de hemorragia catastrófica?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Cesárea programada multidisciplinaria con histerectomía sin intentar desprendimiento manual de la placenta. *

Explicación: El acretismo en alto riesgo debe tratarse de forma planificada por equipo experto.

Intentar extraer placenta invade el plano y precipita sangrado masivo; la conservación uterina es excepcional y no debe ser la estrategia estándar.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de placenta previa y acretismo placentario.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Estados hipertensivos del embarazo

Subtema: Preeclampsia con datos de severidad

Caso clínico 21. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Gestante de 33+5 semanas, previamente normotensa, con cefalea persistente, fosfenos y dolor epigástrico. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: TA repetida 168/112 mmHg, proteinuria no cuantificable de inmediato, plaquetas 92,000/ μ L, AST 92 U/L y creatinina 1.2 mg/dL. Feto con crecimiento en percentil 12 y Doppler conservado. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta integral inmediata?

- A. Hospitalizar, controlar presión arterial severa, administrar sulfato de magnesio y terminar embarazo tras estabilización materna. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La hipertensión severa con trombocitopenia y elevación de transaminasas define severidad.

A las 33 semanas, la prioridad es estabilización, prevención de eclampsia y resolución, no vigilancia expectante prolongada.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Prevención, diagnóstico y tratamiento de preeclampsia-eclampsia.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del embarazo

Subtema: Diabetes mellitus gestacional

Caso clínico 22. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Gestante de 29 semanas con diagnóstico de diabetes gestacional mediante curva diagnóstica; no tiene cetosis ni datos de compromiso fetal. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Durante dos semanas cumple plan nutricional y actividad segura, pero 40% de glucosas en ayuno permanecen entre 100 y 108 mg/dL; posprandiales son aceptables. La técnica de automonitoreo es correcta. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál ajuste está indicado?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar insulinoterapia dirigida al patrón de hiperglucemia, manteniendo intervención nutricional y automonitoreo. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: Persistencia de metas glucémicas fuera de objetivo pese a estilo de vida requiere fármaco; la insulina es el tratamiento de referencia durante embarazo por eficacia y seguridad. No debe esperarse macrosomía para intervenir.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de diabetes en el embarazo.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Trabajo de parto

Subtema: Distocia de progreso

Caso clínico 23. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Primigesta de 40+6 semanas con analgesia regional, membranas rotas y actividad uterina adecuada documentada con catéter. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Alcanza dilatación de 6 cm y permanece sin cambio cervical durante cuatro horas; feto cefálico, monitor categoría I, pelvis sin desproporción evidente. Se propone cesárea por 'fase latente prolongada'. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el diagnóstico y conducta apropiados?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Arresto de dilatación en fase activa; con contracciones adecuadas y cuatro horas sin cambio, indicar cesárea tras reevaluación clínica. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La fase activa inicia a 6 cm. El diagnóstico de arresto requiere ausencia de progreso con contracciones adecuadas durante el intervalo definido; antes de 6 cm no se aplican estos criterios y se debe evitar cesárea prematura.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Vigilancia y atención del trabajo de parto en embarazo de bajo riesgo.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología de trabajo de parto

Subtema: Inducción de trabajo de parto

Caso clínico 24. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Gestante de 41+2 semanas, nulípara, sin cicatriz uterina, feto único cefálico y pruebas de bienestar normal. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Cérvix posterior de 1 cm, 30% de borramiento y estación -3; Bishop 3. No hay placenta previa, infección herpética activa ni sufrimiento fetal. Desea evitar cesárea si es seguro. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál método inicial de maduración cervical es adecuado?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Prostaglandina cervical o método mecánico de maduración, con vigilancia y posterior oxitocina/amniotomía según respuesta. *

Explicación: Con Bishop desfavorable se requiere maduración antes de inducción con oxitocina sola. La elección depende de contexto y contraindicaciones; la cicatriz uterina sería una consideración crítica para prostaglandinas, inexistente en este caso.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Inducción del trabajo de parto en el segundo nivel de atención.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Parto prematuro y patología coriónica

Subtema: Ruptura prematura de membranas pretérmino

Caso clínico 25. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Gestante de 30+4 semanas con salida de líquido claro de seis horas, sin fiebre, dolor uterino ni contracciones.

Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Especuloscopia confirma líquido en fondo vaginal; feto reactivo, sin desprendimiento, cérvix 1 cm. Leucocitos sin desviación y no hay datos de corioamnionitis. Hospital con capacidad neonatal. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál esquema es más apropiado?

A. Manejo expectante hospitalario con antibióticos de latencia, corticosteroides antenatales y vigilancia estrecha de infección y bienestar fetal. *

B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: Antes de 34 semanas, sin infección ni compromiso fetal, prolongar gestación de manera

vigilada mejora resultados neonatales. Los antibióticos reducen morbilidad y aumentan latencia; la tocolisis no se usa de rutina como estrategia prolongada.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de ruptura prematura de membranas pretérmino.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología puerperal

Subtema: Hemorragia obstétrica por atonía

Caso clínico 26. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Puérpera inmediata tras parto vaginal de feto macrosómico, con sangrado estimado de 1,200 mL en minutos. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Útero blando y aumentado de tamaño; canal del parto sin desgarro evidente, placenta completa. TA 92/56 mmHg, FC 122 lpm. Se activa protocolo; tiene dos accesos venosos y no hay hipertensión que contraindique uterotónicos específicos. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es la primera intervención simultánea más importante?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Masaje uterino bimanual, uterotónicos y reanimación hemostática temprana dentro del protocolo de hemorragia obstétrica. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La atonía es la causa más frecuente de hemorragia posparto y exige tratamiento inmediato, paralelo a búsqueda de trauma, tejido y coagulopatía. Retrasar masaje y uterotónicos para hacer estudios puede ser fatal.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Prevención, diagnóstico y manejo de la hemorragia obstétrica.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología puerperal

Subtema: Sepsis materna

Caso clínico 27. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Puérpera de cinco días tras cesárea, con fiebre, dolor abdominal creciente, loquios fétidos y somnolencia. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: TA 84/48 mmHg, FC 132 lpm, lactato 4.6 mmol/L, diuresis 0.3 mL/kg/h. Herida sin dehiscencia. Se obtienen cultivos sin retrasar intervenciones y no hay hemorragia activa. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál paquete terapéutico debe iniciarse durante la primera hora?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Cristaloides, antimicrobianos de amplio espectro, medición seriada de lactato y vasopresor si persiste hipotensión, junto con control de foco. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El choque séptico puerperal requiere reanimación y antibióticos precoces; los cultivos no deben retrasarlos. Debe identificarse foco uterino, herida, urinario u otro, y controlarlo oportunamente.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Prevención, diagnóstico y tratamiento de sepsis materna.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Oncología ginecológica

Subtema: Bartholinitis en mayor de 40 años

Caso clínico 28. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 47 años con masa unilateral de glándula de Bartholin de crecimiento reciente, inicialmente poco dolorosa. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: No hay fiebre; tras antibiótico empírico persiste lesión de 3 cm, firme y parcialmente fija. No tiene antecedentes de quistes recurrentes. Su ginecólogo propone drenaje simple sin estudio. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta es imprescindible?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Biopsia o escisión para excluir neoplasia de glándula de Bartholin, además de manejo según hallazgo. *

Explicación: Una masa nueva de Bartholin en mujer mayor de 40 años requiere evaluación histológica porque el carcinoma, aunque infrecuente, puede simular quiste. El drenaje simple no aporta el diagnóstico necesario.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de patología benigna de vulva.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología mamaria benigna

Subtema: Papiloma intraductal

Caso clínico 29. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 43 años con descarga unilateral, espontánea, serohemática por un solo conducto. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: No palpa masa. Mastografía sin microcalcificaciones; ultrasonido muestra lesión intraductal retroareolar de 7 mm. Citología de secreción es no diagnóstica. No hay signos de mastitis. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente manejo más apropiado?

A. Biopsia con aguja guiada por imagen y escisión dirigida si se confirma papiloma con criterios de riesgo o persistencia de secreción. *

B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La descarga patológica necesita estudio por imagen y tejido; la citología aislada tiene bajo rendimiento. Debe descartarse lesión de alto riesgo o carcinoma, individualizando la resección con correlación radiopatológica.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de patología mamaria benigna.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Control prenatal

Subtema: Hiperemesis gravídica

Caso clínico 30. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Gestante de 10 semanas con vómito persistente, pérdida de 6% del peso, cetonuria y taquicardia; no hay dolor abdominal ni fiebre. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Electrolitos: potasio 3.0 mEq/L; TSH discretamente suprimida sin clínica franca de tirotoxicosis. Ultrasonido confirma gestación única viable. No tolera líquidos por vía oral. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo inicial hospitalario correcto?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Rehidratación intravenosa, tiamina antes de soluciones con dextrosa, corrección electrolítica y antiemético escalonado. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La hiperemesis con deshidratación y alteraciones metabólicas exige hospitalización. La tiamina previene encefalopatía de Wernicke al administrar carbohidratos; no debe atribuirse el cuadro a tiroides sin evaluar gravedad nutricional.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de náusea y vómito en el embarazo.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Control prenatal

Subtema: Hipotiroidismo en embarazo

Caso clínico 31. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Gestante de 8 semanas con tiroidectomía previa, tratada con levotiroxina, acude al primer control. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: TSH 5.8 mUI/L y T4 libre baja para embarazo; toma el medicamento junto con hierro prenatal. Está asintomática, pero pregunta si debe suspenderlo por miedo a malformaciones. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta indicada?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aumentar y ajustar levotiroxina con controles de TSH por trimestre, y separar su ingesta de hierro/calcio. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El hipotiroidismo manifiesto debe corregirse de manera temprana por riesgo materno-fetal.

La levotiroxina es segura; hierro y calcio reducen absorción, por lo que se requiere consejería de administración y seguimiento bioquímico.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de enfermedad tiroidea en el embarazo.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología del embarazo

Subtema: Colestasis intrahepática del embarazo

Caso clínico 32. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Gestante de 35 semanas con prurito intenso palmo-plantar nocturno, sin exantema y con movimientos fetales presentes.

Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Ácidos biliares elevados, aminotransferasas moderadamente elevadas, presión normal y plaquetas normales. No hay dolor epigástrico ni datos de hepatitis viral. Es su primera gestación. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál manejo integra mejor los riesgos materno-fetales?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Ácido ursodesoxicólico para síntomas y planificación del nacimiento según concentración de ácidos biliares y edad gestacional. *

Explicación: La colestasis se asocia a riesgo fetal, especialmente con ácidos biliares muy altos; requiere vigilancia y decisión oportuna de terminación. El ursodesoxicólico mejora prurito y parámetros bioquímicos, sin confundirla con preeclampsia/HELLP.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades hepáticas en el embarazo.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología de trabajo de parto

Subtema: Embarazo gemelar dicorial biamniótico

Caso clínico 33. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Gestante de 37 semanas con gemelos dicoriales biamnióticos, ambos con crecimiento adecuado. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Gemelo A en presentación cefálica, gemelo B transverso; no hay placenta previa, restricción ni preeclampsia. Equipo con experiencia en maniobras obstétricas y quirófano disponible. La paciente pregunta si la cesárea es obligatoria. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál opción es razonable?

- A. Ofrecer parto vaginal planificado si el primer gemelo es cefálico y existen condiciones, experiencia y capacidad de resolución inmediata. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: En gemelar dicorial sin complicaciones, la presentación cefálica del primer gemelo permite considerar parto vaginal. La decisión exige personal experto y consentimiento; la presentación del segundo no obliga por sí sola a cesárea.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Atención del embarazo gemelar.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia**Tema: Sangrado uterino anormal anatómico no maligno****Subtema: Torsión anexial**

Caso clínico 34. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 24 años con dolor pélvico unilateral súbito, náusea y vómito, sin fiebre ni sangrado. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Ultrasonido muestra ovario de 8 cm con quiste simple y edema; Doppler con flujo arterial presente. Prueba de embarazo negativa; analgesia no mejora. Se propone alta porque el flujo descarta torsión. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta correcta?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Laparoscopia urgente para destorsión y conservación ovárica cuando sea viable. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El flujo Doppler conservado no excluye torsión por doble irrigación. La sospecha clínica con masa anexial y dolor agudo exige evaluación quirúrgica rápida; la destorsión se prefiere aun si el ovario luce congestivo.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de torsión anexial.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Hemorragias del segundo trimestre

Subtema: Desprendimiento prematuro de placenta normoinsera

Caso clínico 35. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Gestante de 34 semanas con hipertensión crónica y dolor abdominal intenso tras inicio de sangrado oscuro escaso.

Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Útero hipertónico y sensible, feto con bradicardia persistente. No hay placenta previa. TA 150/95 mmHg, fibrinógeno en descenso y no hay antecedente traumático. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta más indicada?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Reanimación materna inmediata y terminación expedita del embarazo por cesárea ante compromiso fetal agudo. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El dolor, hipertonía y sangrado oscuro sugieren DPPNI; la cantidad exteriorizada puede subestimar la hemorragia. Con feto vivo comprometido se requiere resolución urgente, junto con corrección de coagulopatía.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de desprendimiento prematuro de placenta normoinsera.

Especialidad: Ginecología y Obstetricia

Tema: Patología puerperal

Subtema: Choque hemorrágico obstétrico

Caso clínico 36. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Paciente con hemorragia posparto masiva, piel fría, confusión y TA 70/40 mmHg tras atonía refractaria. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Se ha realizado masaje, uterotónicos y balón intrauterino; continúa sangrando. Se activa protocolo transfusional y se dispone de quirófano. Gasometría con acidosis metabólica y fibrinógeno bajo. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál principio de reanimación debe guiar el manejo?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Control simultáneo de la fuente de sangrado con reanimación hemostática balanceada y corrección precoz de fibrinógeno/coagulopatía. *

Explicación: El choque obstétrico hemorrágico no se corrige con cristaloides en exceso ni con espera. Debe realizarse control quirúrgico escalonado y transfusión dirigida, minimizando hipotermia, acidosis y coagulopatía.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Prevención, diagnóstico y manejo de la hemorragia obstétrica.

Especialidad: Pediatría

Tema: Recién nacido sano

Subtema: Tamiz auditivo neonatal

Caso clínico 37. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Recién nacido a término, sin complicaciones, egresará a las 36 horas de vida con exploración física normal. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Su madre pregunta si el tamiz auditivo puede esperar hasta que note retraso del lenguaje. No hay antecedente familiar conocido, pero el niño nació en institución con programa de detección neonatal. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál recomendación es correcta?

- A. Realizar tamiz auditivo antes del egreso o durante el primer mes de vida y asegurar ruta diagnóstica si no pasa. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La detección temprana permite intervención dentro de la ventana crítica de lenguaje. Un recién nacido aparentemente sano puede tener hipoacusia; esperar síntomas retrasa confirmación y rehabilitación.

Fuente: Secretaría de Salud/CENETEC. Guía de Práctica Clínica: Tamiz auditivo neonatal e intervención temprana.

Especialidad: Pediatría

Tema: Reanimación neonatal

Subtema: Ventilación a presión positiva

Caso clínico 38. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Recién nacido de 38 semanas tras líquido meconial, hipotónico y sin llanto al nacimiento. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tras pasos iniciales de calor, posición y secado, presenta apnea y frecuencia cardíaca de 70 lpm. No hay evidencia de obstrucción visible; se dispone de equipo con máscara del tamaño adecuado. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál intervención debe iniciarse sin demora?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Ventilación a presión positiva eficaz, reevaluando frecuencia cardíaca y movimiento torácico.
- * C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La apnea o frecuencia cardíaca menor de 100 lpm tras pasos iniciales indica ventilación; ésta es la maniobra más importante de reanimación neonatal. La aspiración traqueal rutinaria por meconio no debe retrasar ventilación.

Fuente: Secretaría de Salud/CENETEC. Guía de Práctica Clínica: Reanimación neonatal.

Especialidad: Pediatría**Tema: Patología neonatal infecciosa****Subtema: Sepsis neonatal temprana**

Caso clínico 39. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Recién nacido de 35 semanas, 3 horas de vida, hijo de madre con corioamnionitis y fiebre intraparto. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Presenta letargia, inestabilidad térmica, quejido y llenado capilar lento. Se toman hemocultivos; glucosa baja y radiografía no concluyente. No hay malformación aparente. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta antimicrobiana inicial?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Iniciar ampicilina más gentamicina tras toma de cultivos, junto con soporte y vigilancia estrecha. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La clínica y factores maternos establecen alta sospecha de sepsis temprana. El tratamiento empírico debe cubrir los patógenos habituales y no esperar resultados si el neonato está sintomático.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Prevención, diagnóstico y tratamiento de sepsis neonatal.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología respiratoria neonatal

Subtema: Enfermedad de membrana hialina

Caso clínico 40. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Prematuro de 29 semanas con dificultad respiratoria progresiva desde los primeros minutos de vida. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene taquipnea, quejido, retracciones y requiere FiO₂ creciente. Radiografía con volumen pulmonar bajo y patrón reticulogranular difuso con broncograma aéreo. Madre no recibió esquema completo de esteroides. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento respiratorio específico debe considerarse de forma temprana?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. CPAP nasal precoz y administración selectiva de surfactante si aumenta requerimiento de oxígeno o hay falla respiratoria. *

Explicación: El déficit de surfactante causa síndrome de dificultad respiratoria del prematuro. El soporte no invasivo temprano reduce intubación; surfactante se indica según gravedad, evitando ventilación invasiva innecesaria.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria neonatal.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología neonatal malformativa

Subtema: Hernia diafragmática congénita

Caso clínico 41. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Recién nacido con dificultad respiratoria severa al nacer, abdomen excavado y ruidos intestinales en hemitórax izquierdo. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Saturación preductal baja, desviación mediastinal en radiografía y ventilación con máscara iniciada por personal no especializado. Se sospecha hipoplasia pulmonar e hipertensión pulmonar asociada. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál medida inmediata es la más importante?

- A. Intubación endotraqueal y descompresión gástrica con sonda, evitando ventilación con bolsa-máscara. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La ventilación con máscara insufla intestino y agrava compresión pulmonar. La estabilización ventilatoria suave y descompresión gástrica preceden la reparación quirúrgica; la cirugía no es la primera intervención en neonato inestable.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de hernia diafragmática congénita.

Especialidad: Pediatría**Tema: Patología neonatal congénita infecciosa****Subtema: Sífilis congénita**

Caso clínico 42. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Recién nacido de madre con VDRL alto y tratamiento incompleto iniciado siete días antes del parto. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: El neonato tiene rinitis sanguinolenta, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia y lesiones óseas metafisarias en radiografías. VDRL neonatal es cuatro veces el título materno; LCR pendiente. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál manejo está indicado?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Penicilina G cristalina intravenosa por 10 días, con evaluación completa de sífilis congénita.

*

- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La enfermedad clínica y títulos comparativos hacen altamente probable sífilis congénita.

El retraso o tratamiento materno inadecuado no protege al neonato; penicilina parenteral es esencial.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Prevención, diagnóstico y tratamiento de sífilis congénita.

Especialidad: Pediatría**Tema: Ictericia neonatal****Subtema: Hiperbilirrubinemia por hemólisis**

Caso clínico 43. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Recién nacido de 37 semanas, grupo A Rh positivo, madre O Rh positivo, ictericia a las 10 horas de vida. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Bilirrubina total asciende rápidamente, Coombs directo positivo, reticulocitos elevados y Hb en descenso. Está activo, pero el valor cruza umbral de fototerapia intensiva ajustado a edad y factores de riesgo. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es la intervención inmediata apropiada?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Iniciar fototerapia intensiva y vigilar bilirrubina seriada; escalar según umbrales para inmunoglobulina/exanguinotransfusión. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La ictericia en primeras 24 horas con hemólisis es patológica. La fototerapia eficaz reduce bilirrubina no conjugada; los umbrales deben considerar edad gestacional y riesgo neurotóxico, no una cifra aislada.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de hiperbilirrubinemia neonatal.

Especialidad: Pediatría

Tema: Tamiz metabólico

Subtema: Hipotiroidismo congénito

Caso clínico 44. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Recién nacido de 12 días con tamiz reportado como TSH muy elevada; está clínicamente poco sintomático. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Confirmación muestra TSH elevada y T4 libre disminuida. No hay que esperar gammagrama tiroideo para establecer etiología; familia pregunta si puede repetir estudio en un mes antes de iniciar tratamiento. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta es correcta?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Iniciar levotiroxina de inmediato tras confirmación, sin retrasarla por estudios etiológicos.

*

Explicación: El tratamiento precoz, idealmente en las primeras dos semanas, previene discapacidad intelectual. La causa puede estudiarse después si no posterga tratamiento; la apariencia normal no excluye daño neurocognitivo progresivo.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de hipotiroidismo congénito.

Especialidad: Pediatría

Tema: Crecimiento y desarrollo

Subtema: Maltrato infantil - trauma craneal

Caso clínico 45. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Lactante de 5 meses con irritabilidad, vómitos y convulsión; cuidador refiere caída desde sofá sin testigos. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Exploración: equimosis en pabellón auricular y tronco, fontanela tensa. TAC muestra hematoma subdural bilateral de diferente antigüedad; fondo de ojo con hemorragias retinianas extensas. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta médico-legal y clínica inicial?

A. Estabilizar, documentar lesiones, realizar evaluación integral de maltrato y notificar conforme a la normatividad de protección infantil. *

B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La historia incongruente y lesiones de alta especificidad obligan a sospechar maltrato. La prioridad es proteger al menor y tratar lesiones; la notificación es una responsabilidad clínica, no una decisión opcional de la familia.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Detección y atención del maltrato infantil.

Especialidad: Pediatría**Tema: Vacunación****Subtema: Esquema de vacunación en inmunocompromiso**

Caso clínico 46. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Niño de 4 años con leucemia linfoblástica aguda en quimioterapia de mantenimiento, sin fiebre ni neutropenia actual.

Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene esquema incompleto y la familia solicita 'poner todas las vacunas' hoy, incluida vacuna triple viral. Convive con hermanos sanos y no tiene antecedente de reacción anafiláctica a vacunas. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál decisión es correcta?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Diferir vacunas vivas atenuadas durante inmunosupresión y aplicar vacunas inactivadas conforme a evaluación del esquema y condición clínica. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: Las vacunas vivas pueden causar enfermedad en inmunosupresión significativa. Las inactivadas suelen ser seguras aunque la respuesta sea menor; la recuperación y coordinación con oncología definen reanudación de vivas.

Fuente: Secretaría de Salud. Manual de vacunación universal vigente.

Especialidad: Pediatría**Tema: Patología gastrointestinal pediátrica****Subtema: Invaginación intestinal**

Caso clínico 47. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Lactante de 9 meses previamente sano con episodios de llanto intenso, flexión de piernas y vómito. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Entre episodios permanece somnoliento. Presenta evacuación con moco y sangre; abdomen con masa en 'salchicha'. Está estable, sin peritonismo ni perforación en radiografía. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo diagnóstico-terapéutico inicial?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Reducción con enema neumático o hidrostático guiado por imagen en centro con respaldo quirúrgico. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: En invaginación estable sin perforación ni peritonitis, el enema es diagnóstico y terapéutico. La cirugía se reserva para inestabilidad, perforación, peritonitis o reducción fallida.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de invaginación intestinal.

Especialidad: Pediatría**Tema: Diarrea en pediatría****Subtema: Deshidratación por diarrea aguda**

Caso clínico 48. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Niña de 18 meses con 24 horas de diarrea acuosa y vómitos, sin sangre ni fiebre alta. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Está inquieta, ojos ligeramente hundidos, bebe con avidez, pliegue cutáneo retorna lentamente y perfusión es adecuada. No hay letargia, pulso débil ni incapacidad para beber. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Qué plan de hidratación es apropiado?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Plan B con solución de rehidratación oral supervisada, reevaluación clínica y continuación de alimentación/lactancia. *

Explicación: Tiene algunos signos de deshidratación, pero no choque. La rehidratación oral es efectiva y evita intervenciones invasivas; bebidas azucaradas o antidiarreicos no sustituyen solución de rehidratación oral.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Prevención, diagnóstico y tratamiento de diarrea aguda en niños.

Especialidad: Pediatría**Tema: Enfermedades parasitarias****Subtema: Giardiasis**

Caso clínico 49. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Escolar de 7 años con distensión abdominal, flatulencia, evacuaciones fétidas y pérdida ponderal tras excursión a zona rural. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: No tiene fiebre ni sangre en heces. Coproparasitológico seriado identifica trofozoítos/quistes compatibles; su hermana menor tiene síntomas similares. No hay datos de deshidratación grave. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento es más apropiado?

A. Tinidazol en dosis única o metronidazol según esquema, más medidas de higiene y evaluación de contactos sintomáticos. *

B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La clínica de malabsorción y hallazgo parasitológico son compatibles con *Giardia*. El tratamiento antiparasitario debe acompañarse de prevención de reinfección por agua y manos contaminadas.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de giardiasis.

Especialidad: Pediatría**Tema: Patología respiratoria del lactante y preescolar****Subtema: Bronquiolitis**

Caso clínico 50. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Lactante de 5 meses con primer episodio de sibilancias, rinorrea de tres días y dificultad para alimentarse. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: SatO₂ 92% al aire ambiente, tiraje subcostal leve, sin apnea; auscultación con sibilancias y crépitos difusos. No tiene cardiopatía ni antecedente de sibilancias recurrentes. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál manejo es más adecuado?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Medidas de soporte, aseo nasal, hidratación y oxígeno si persiste hipoxemia; no usar broncodilatadores o antibióticos de rutina. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La bronquiolitis es diagnóstico clínico y el tratamiento es principalmente de soporte. La respuesta a broncodilatador no es consistente; antibióticos no aportan en ausencia de sospecha bacteriana.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de bronquiolitis aguda.

Especialidad: Pediatría**Tema: Neumonías****Subtema: Neumonía adquirida en la comunidad**

Caso clínico 51. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Niña de 3 años con fiebre, tos y taquipnea; no tiene dificultad respiratoria grave ni hipoxemia. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: FR 48/min, crepitos focales derechos, SatO₂ 96%, tolera líquidos y no ha recibido antibióticos. Radiografía no es necesaria para decisión ambulatoria y no hay brote de influenza. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál antibiótico oral inicial es de elección?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Amoxicilina a dosis adecuada para neumococo, con reevaluación clínica. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: En preescolar con neumonía bacteriana probable no complicada, amoxicilina es el tratamiento empírico preferido. Macrólido no es primera elección sin sospecha de patógeno atípico; la radiografía no es rutinaria en paciente estable.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad en niños.

Especialidad: Pediatría**Tema: Asma en pediatría****Subtema: Exacerbación asmática grave**

Caso clínico 52. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Escolar de 9 años con asma persistente, acude por disnea tras abandonar controlador inhalado. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Habla en palabras, usa músculos accesorios, SatO₂ 89%, PEF 40% del mejor personal. Tras tres nebulizaciones de salbutamol y ipratropio persiste trabajo respiratorio importante. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál intervención debe añadirse tempranamente?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Corticosteroide sistémico y oxígeno titulado, considerando sulfato de magnesio IV por mala respuesta inicial. *

Explicación: La exacerbación grave requiere broncodilatador repetido, oxígeno y esteroide sistémico precoz. El magnesio se considera cuando persiste obstrucción severa; antibióticos y sedación no son tratamientos del broncoespasmo.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento del asma en niños.

Especialidad: Pediatría**Tema: IRAS y convulsiones****Subtema: Faringoamigdalitis estreptocócica**

Caso clínico 53. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Niño de 8 años con odinofagia intensa, fiebre, exudado amigdalár y adenopatías cervicales anteriores dolorosas. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: No tiene tos, conjuntivitis ni rinorrea. Prueba rápida para estreptococo del grupo A es positiva. No es alérgico a penicilina y puede deglutir. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento previene mejor complicaciones no supurativas?

- A. Penicilina o amoxicilina durante el esquema completo recomendado. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: Una prueba positiva en contexto clínico compatible confirma faringitis estreptocócica. Los beta-lactámicos adecuados erradican el patógeno y previenen fiebre reumática; acortar el curso por mejoría no es apropiado.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de faringoamigdalitis aguda en niños.

Especialidad: Pediatría**Tema: Enfermedades exantemáticas****Subtema: Enfermedad de Kawasaki**

Caso clínico 54. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Niño de 3 años con fiebre de siete días, conjuntivitis bilateral no purulenta, labios fisurados y exantema polimorfo.

Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene edema de manos, adenopatía cervical de 2 cm y elevación de PCR. Ecocardiograma inicial sin aneurismas. Cultivos negativos; recibió antibióticos sin respuesta. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento debe administrarse sin retrasar?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Inmunoglobulina intravenosa más ácido acetilsalicílico, con evaluación cardiológica seriada. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: Kawasaki clásico requiere terapia antes del día 10 idealmente para reducir aneurismas coronarios. Un ecocardiograma inicial normal no descarta inflamación coronaria ni justifica diferir inmunoglobulina.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de enfermedad de Kawasaki.

Especialidad: Pediatría**Tema: Urgencias pediátricas****Subtema: Intoxicación por paracetamol**

Caso clínico 55. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Adolescente de 14 años ingiere voluntariamente cantidad desconocida de paracetamol hace 10 horas. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Está asintomático, con signos vitales normales. Nivel sérico se obtiene en ventana adecuada; transaminasas iniciales normales. No se debe confiar en ausencia de síntomas para descartar toxicidad. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál antídoto debe iniciarse si el nivel cruza línea de tratamiento o la ingesta es potencialmente tóxica?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. N-acetilcisteína, sin retrasar por pruebas hepáticas inicialmente normales. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La hepatotoxicidad puede ser tardía; el nomograma y el tiempo desde ingestión guían tratamiento. N-acetilcisteína es más eficaz precozmente, pero también aporta beneficio en presentación tardía con riesgo.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de intoxicación aguda en pediatría.

Especialidad: Pediatría**Tema: Uropediatria****Subtema: Torsión testicular**

Caso clínico 56. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Adolescente de 15 años con dolor testicular unilateral súbito de dos horas, náusea y vómito durante entrenamiento deportivo. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Testículo alto, horizontal, muy doloroso; reflejo cremastérico ausente. No disuria, fiebre ni antecedente de trauma. En urgencias se plantea esperar ultrasonido Doppler porque es de madrugada. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta es la más apropiada?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Exploración quirúrgica urgente con detorsión y orquidopexia bilateral si la sospecha clínica es alta. *

Explicación: La ventana de viabilidad testicular es corta y la clínica clásica no debe retrasarse por imagen. La orquidopexia contralateral previene torsión futura por anomalía anatómica compartida.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de torsión testicular.

Especialidad: Pediatría

Tema: Cardiopedía

Subtema: Transposición de grandes vasos

Caso clínico 57. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Recién nacido a término con cianosis intensa desde primeras horas de vida, poca respuesta a oxígeno y sin soplo llamativo. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Gasometría confirma hipoxemia; ecocardiograma revela transposición de grandes arterias con comunicación interauricular restrictiva. Recibe prostaglandina E1 para mantener ductus permeable. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál intervención puede ser necesaria de forma urgente para mejorar mezcla sanguínea?

- A. Septostomía auricular con balón, mientras se prepara corrección quirúrgica definitiva. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: En TGA, la vida depende de mezcla entre circuitos. Prostaglandina mantiene ductus, pero una comunicación auricular restrictiva puede requerir septostomía; oxígeno aislado no corrige la fisiología paralela.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de cardiopatías congénitas cianógenas.

Especialidad: Pediatría**Tema: Especialidades pediátricas****Subtema: Púrpura de Henoch-Schönlein**

Caso clínico 58. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Niño de 8 años con púrpura palpable simétrica en piernas, artralgia de tobillos y dolor abdominal cólico. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Plaquetas normales, función renal normal, examen de orina con hematuria microscópica y proteinuria leve. No hay choque ni invaginación. Madre teme que sea leucemia por las lesiones cutáneas. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Qué seguimiento es indispensable?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Control seriado de presión arterial y examen de orina/función renal para detectar nefritis por IgA. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La púrpura con plaquetas normales y síntomas articulares-abdominales sugiere vasculitis

IgA. El pronóstico depende de compromiso renal, que puede aparecer después; esteroides no sustituyen vigilancia renal.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de púrpura de Henoch-Schönlein.

Especialidad: Pediatría**Tema: Alteraciones cromosómicas****Subtema: Síndrome de Down - tamiz cardiaco**

Caso clínico 59. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Recién nacido con hipotonía, fisuras palpebrales oblicuas, pliegue palmar único y cariotipo que confirma trisomía 21.

Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Se alimenta con dificultad leve, sin cianosis ni soplo evidente. Saturación normal. Los padres desean egreso precoz y preguntan si el ecocardiograma se requiere sólo cuando hay soplo. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál estudio debe solicitarse en etapa neonatal?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Ecocardiograma para detectar cardiopatía congénita, independientemente de auscultación aparentemente normal. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La prevalencia de cardiopatía congénita es alta en trisomía 21 y un soplo puede ser ausente inicialmente. La evaluación temprana permite planear seguimiento y tratamiento oportuno.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Atención integral de personas con síndrome de Down.

Especialidad: Pediatría**Tema: Patología neonatal infecciosa****Subtema: Enterocolitis necrosante**

Caso clínico 60. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Prematuro de 28 semanas, día 12 de vida, inicia distensión abdominal, residuo bilioso y apnea. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Abdomen doloroso, plaquetas en descenso y radiografía con neumatosis intestinal. No hay perforación libre. Recibía alimentación enteral con fórmula por limitaciones de banco de leche. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál manejo inicial es correcto?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Suspender vía enteral, descomprimir con sonda, iniciar antibióticos de amplio espectro y soporte intensivo con valoración quirúrgica. *

Explicación: La neumatosis establece enterocolitis necrosante. El tratamiento inicial es médico intensivo y vigilancia de perforación; continuar alimentación enteral aumenta lesión. La cirugía se indica ante perforación o deterioro refractario.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de enterocolitis necrosante.

Especialidad: Pediatría**Tema: Patología respiratoria neonatal****Subtema: Apnea del prematuro**

Caso clínico 61. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Prematuro de 30 semanas, día 5 de vida, tiene pausas respiratorias de 25 segundos con bradicardia y desaturación que responden a estimulación. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: No hay sepsis, hipoglucemia, anemia significativa, convulsiones ni alteración térmica. Recibe CPAP de bajo flujo y radiografía sin nueva patología. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento farmacológico es apropiado tras excluir causas secundarias?

- A. Cafeína citrato, con monitorización cardiorrespiratoria. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La apnea del prematuro es diagnóstico de exclusión y la cafeína estimula el centro respiratorio, reduciendo episodios y soporte ventilatorio. No debe etiquetarse como apnea de prematuridad sin buscar infección u otros desencadenantes.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de apnea del prematuro.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología neonatal malformativa

Subtema: Atresia esofágica con fístula distal

Caso clínico 62. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Recién nacido con sialorrea abundante, tos, cianosis durante intentos de alimentación y distensión abdominal. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: La sonda orogástrica no progresa y se enrolla en radiografía; hay gas intestinal. Ecografía prenatal mostró polihidramnios. No se ha intentado alimentar nuevamente. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál medida preoperatoria es esencial?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Suspender alimentación oral, colocar sonda en bolsa proximal con aspiración continua y elevar la cabeza, con evaluación de anomalías asociadas. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La sonda en bolsa proximal y gas abdominal sugieren atresia con fístula distal. Aspiración de secreciones y prevención de aspiración estabilizan al neonato hasta reparación; alimentar por vía oral es peligroso.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de atresia esofágica.

Especialidad: Pediatría**Tema: Crecimiento y desarrollo****Subtema: Obesidad infantil**

Caso clínico 63. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Niño de 11 años, IMC por arriba del percentil 99, acantosis nigricans y antecedente familiar de diabetes tipo 2. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene presión arterial en percentil 96 para edad/talla, ALT elevada y glucosa en ayuno límite. Pasa cinco horas diarias frente a pantallas y consume bebidas azucaradas; no hay fármacos causales. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál enfoque es el indicado?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Intervención familiar multicomponente sobre alimentación, actividad física y conducta, con evaluación y manejo de comorbilidades metabólicas. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La obesidad pediátrica exige tratamiento estructurado, no dietas punitivas aisladas.

Acantosis, hipertensión y ALT elevada obligan a buscar resistencia a insulina, dislipidemia y enfermedad hepática grasa.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Prevención, diagnóstico y tratamiento de sobrepeso y obesidad en niños.

Especialidad: Pediatría**Tema: Patología gastrointestinal pediátrica****Subtema: Enfermedad de Hirschsprung**

Caso clínico 64. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Recién nacido de término que no expulsó meconio en las primeras 48 horas y presenta distensión progresiva. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene vómito bilioso y al tacto rectal sale explosivamente material fecal y gas. Radiografía con asas dilatadas; enema contrastado sugiere zona de transición rectosigmoidea. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál estudio confirma el diagnóstico?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Biopsia rectal por succión que demuestre ausencia de células ganglionares. *

Explicación: La clínica y estudio contrastado sugieren aganglioneosis, pero la confirmación es histológica. El tacto que descomprime no resuelve la obstrucción; debe estabilizarse y evitar enterocolitis.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de enfermedad de Hirschsprung.

Especialidad: Pediatría**Tema: Diarrea en pediatría****Subtema: Enfermedad celíaca**

Caso clínico 65. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Niña de 4 años con distensión abdominal, diarrea crónica, anemia ferropénica resistente y desaceleración ponderal.

Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Consume trigo diariamente; no tiene nefropatía ni parasitosis documentada. IgA total normal y anti-transglutaminasa tisular IgA muy elevada. La familia ya retiró gluten desde hace tres días por internet. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso diagnóstico-terapéutico apropiado?

A. Referir para confirmación diagnóstica según protocolo mientras mantiene dieta con gluten hasta completar evaluación, y luego instaurar dieta estricta sin gluten. *

B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La serología positiva requiere integración especializada y, con frecuencia, confirmación histológica conforme a títulos y protocolo. Retirar gluten antes de concluir evaluación puede falsear resultados; el tratamiento definitivo es dieta sin gluten mantenida.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de enfermedad celíaca en niños.

Especialidad: Pediatría**Tema: Urgencias pediátricas****Subtema: Ingesta de cáusticos**

Caso clínico 66. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Niño de 2 años ingiere destapacaños alcalino hace 40 minutos; tiene sialorrea y dolor oral, pero no estridor. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Padres indujeron un pequeño vómito antes de llegar. Está estable, sin perforación evidente. Un familiar propone darle leche y neutralizar con limón. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta debe evitarse y cuál es el manejo inicial?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. No inducir vómito ni neutralizar; mantener ayuno, proteger vía aérea si precisa y valorar endoscopia temprana por equipo experto. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La reexposición esofágica durante vómito y reacciones exotérmicas de neutralización agravan daño. La evaluación endoscópica se considera según síntomas y producto, tras estabilización de la vía aérea.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones agudas en pediatría.

Especialidad: Pediatría**Tema: Uropediatría****Subtema: Infección urinaria febril**

Caso clínico 67. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Lactante de 7 meses con fiebre de 39.2°C sin foco, irritable y con vómito ocasional. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: EGO por cateterismo con piuria y nitritos; urocultivo crece E. coli significativa. Está hidratado y tolera vía oral luego de observación. No hay aspecto tóxico ni sepsis. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el plan apropiado tras confirmar IVU?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Antibiótico dirigido con duración adecuada y ultrasonido renal-vesical después del primer episodio febril según edad/guía. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La IVU febril en lactante requiere muestra adecuada, tratamiento y evaluación anatómica inicial. La profilaxis antibiótica y cistouretrografía no se indican automáticamente en todos; dependen de hallazgos y recurrencia.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de infección de vías urinarias en niños.

Especialidad: Pediatría

Tema: Cardiopedia

Subtema: Tetralogía de Fallot - crisis hipoxémica

Caso clínico 68. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Lactante de 6 meses con tetralogía de Fallot conocida presenta llanto, cianosis brusca y taquipnea durante defecación. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: SatO₂ cae a 55%; está irritable, con soplo que disminuye de intensidad. No tiene fiebre ni signos de insuficiencia cardíaca. Madre indica que episodios breves previos cedieron al cargarlo. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál maniobra inicial puede mejorar el episodio?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Colocar en posición genupectoral, administrar oxígeno y medidas para disminuir espasmo del tracto de salida, escalando según respuesta. *

Explicación: La posición genupectoral aumenta resistencia sistémica y reduce cortocircuito derecha-izquierda en la crisis hipoxémica. Debe tratarse como urgencia y evaluar desencadenantes; no es una simple crisis de ansiedad.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de tetralogía de Fallot.

Especialidad: Pediatría**Tema: Especialidades pediátricas****Subtema: Nefroblastoma**

Caso clínico 69. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Niño de 3 años con masa abdominal unilateral descubierta por su madre al bañarlo, sin dolor ni hematuria visible.

Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Ultrasonido y tomografía muestran masa renal bien delimitada, sin cruce de línea media ni invasión vascular evidente. Presión arterial elevada; no se ha realizado biopsia percutánea. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta inicial es apropiada?

A. Referencia a equipo oncológico-quirúrgico para estadificación y nefrectomía primaria conforme al protocolo, evitando biopsia rutinaria en tumor resecable típico. *

B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El tumor de Wilms se maneja en protocolos multidisciplinarios. En lesión típica resecable, la biopsia inicial puede cambiar estadificación y no es rutinaria; la hipertensión puede relacionarse con renina.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de tumor de Wilms.

Especialidad: Pediatría**Tema: Alteraciones cromosómicas****Subtema: Síndrome de Edwards**

Caso clínico 70. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Recién nacido con restricción del crecimiento, occipucio prominente, puños cerrados con dedos sobrepuestos y pies en mecedora. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Ecocardiograma muestra comunicación interventricular; presenta dificultades de alimentación. Cariotipo confirma trisomía 18. Padres solicitan información sobre manejo y no desean decisiones precipitadas. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál enfoque es éticamente y clínicamente apropiado?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Consejería pronóstica no directiva y plan individualizado centrado en objetivos familiares, cuidados de confort y tratamiento proporcional. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La trisomía 18 implica alta mortalidad y comorbilidad compleja, pero las decisiones deben ser compartidas y respetuosas. El diagnóstico no justifica negar de forma automática toda atención ni imponer intervenciones sin objetivos acordados.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Atención integral de pacientes pediátricos con alteraciones cromosómicas.

Especialidad: Pediatría**Tema: Recién nacido sano****Subtema: Cefalohematoma**

Caso clínico 71. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Recién nacido de 2 días después de parto instrumentado, con masa parietal blanda, bien delimitada, que no cruza suturas. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Está hemodinámicamente estable y el perímetro cefálico no aumenta. Tiene ictericia leve en vigilancia, sin palidez ni signos neurológicos. Familia solicita punción para vaciar el bulto. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál manejo es correcto?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Observación clínica y vigilancia de hiperbilirrubinemia; no aspirar el cefalohematoma. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El cefalohematoma es subperióstico y no cruza suturas. Usualmente se resuelve espontáneamente; aspirarlo aumenta riesgo de infección. Debe vigilarse ictericia por reabsorción sanguínea.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Atención del recién nacido sano.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología neonatal congénita infecciosa

Subtema: Toxoplasmosis congénita

Caso clínico 72. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Recién nacido con hidrocefalia, calcificaciones intracraneales difusas y coriorretinitis. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Madre refiere consumo de carne poco cocida y no tuvo tamizaje prenatal. Serología neonatal y estudios confirmatorios apoyan infección congénita. El recién nacido tiene anemia y hepatomegalia. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál esquema terapéutico se indica?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Pirimetamina, sulfadiazina y ácido fólico bajo seguimiento especializado prolongado. *

Explicación: La tríada clínica obliga a tratamiento temprano de toxoplasmosis congénita. El ácido fólico reduce toxicidad hematológica de pirimetamina; el seguimiento oftalmológico y neurológico es indispensable.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de toxoplasmosis congénita.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología neonatal malformativa

Subtema: Gastrosquisis

Caso clínico 73. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Recién nacido con asas intestinales expuestas a la derecha del cordón, sin saco que las cubra. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Está hipotérmico, con pérdidas importantes por evaporación, pero perfusión aceptable. El intestino aparece edematoso sin necrosis evidente. Equipo plantea intentar introducir asas de inmediato en sala de partos. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál manejo inicial es correcto?

- A. Cubrir vísceras con material estéril plástico, descompresión gástrica, reanimación térmica-hídrica y traslado para cierre/silo. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La prioridad es evitar pérdida de calor y líquidos, trauma y contaminación. La reducción forzada puede aumentar presión intraabdominal y comprometer ventilación/perfusión; el cierre se individualiza.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de gastrosquisis.

Especialidad: Pediatría**Tema: Patología respiratoria del lactante y preescolar****Subtema: Tos ferina**

Caso clínico 74. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Lactante de 2 meses, sin vacunas completas, con accesos de tos paroxística, cianosis y apnea, sin fiebre alta. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Leucocitosis con linfocitosis marcada; radiografía sin consolidación. Hermano escolar presenta tos persistente. Está en observación por edad y episodios de desaturación. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento y medida de salud pública se indican?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Macrólido para el caso y profilaxis/tratamiento de contactos cercanos según indicación, más aislamiento por gotas. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La clínica en lactante y linfocitosis sugieren pertussis. El macrólido reduce transmisión, aunque no siempre modifica curso si se inicia tarde; los lactantes pequeños requieren vigilancia por riesgo de apnea.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de tos ferina.

Especialidad: Pediatría**Tema: Patología gastrointestinal pediátrica****Subtema: ERGE con signos de alarma**

Caso clínico 75. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Lactante de 4 meses con regurgitación desde nacimiento, ahora con rechazo persistente de alimento, hematemesis escasa y pobre ganancia ponderal. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: No hay fiebre ni diarrea, pero tiene arqueos dolorosos y antecedente de episodio de apnea. Alimentación fraccionada y medidas posturales no han mejorado; exploración neurológica normal. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta es más apropiada?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Referir para evaluación diagnóstica por síntomas de alarma y descartar causas estructurales/complicaciones antes de tratamiento empírico prolongado. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La regurgitación fisiológica no causa deterioro ponderal, sangrado ni eventos respiratorios. Los signos de alarma requieren evaluación; supresores ácidos no son respuesta rutinaria para todo lactante que regurgita.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de reflujo gastroesofágico en pediatría.

Especialidad: Pediatría**Tema: Enfermedades exantemáticas****Subtema: Sarampión**

Caso clínico 76. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Niño de 6 años no vacunado con fiebre alta, tos, coriza, conjuntivitis y manchas de Koplik, seguido de exantema maculopapular descendente. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: En la escuela hay varios enfermos. Tiene neumonía leve en evaluación. La familia solicita antibiótico y regreso a clases cuando baje la fiebre. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál medida es obligatoria además del soporte?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Notificación epidemiológica inmediata, aislamiento respiratorio y administración de vitamina A según edad/protocolo. *

Explicación: Sarampión es enfermedad de notificación urgente y altamente contagiosa. La vitamina A reduce complicaciones en niños; antibióticos sólo se usan si hay coinfección bacteriana documentada.

Fuente: Secretaría de Salud. Manual de procedimientos estandarizados para vigilancia epidemiológica de enfermedad febril exantemática.

Especialidad: Pediatría**Tema: Especialidades pediátricas****Subtema: Púrpura trombocitopénica inmune**

Caso clínico 77. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Niña de 5 años con petequias y equimosis tras infección viral reciente, sin fiebre ni pérdida de peso. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Plaquetas 12,000/ μ L, Hb y leucocitos normales, frotis sin blastos. Tiene epistaxis leve controlada, no sangrado mucoso importante ni cefalea. Padres piden transfusión de plaquetas inmediata. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta puede ser apropiada?

- A. Observación estrecha o tratamiento con inmunoglobulina/corticosteroide según sangrado y contexto, no transfusión plaquetaria rutinaria. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La PTI típica aislada se maneja según sangrado, no sólo cifra plaquetaria. Las plaquetas transfundidas se destruyen rápidamente y se reservan para hemorragia grave junto con terapias de rescate.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de púrpura trombocitopénica inmune en niños.

Especialidad: Pediatría

Tema: Patología neonatal infecciosa

Subtema: Meningitis neonatal

Caso clínico 78. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Recién nacido de 18 días con fiebre, irritabilidad, fontanela abombada y rechazo al alimento. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Está perfundido tras estabilización inicial; hemocultivo tomado. Punción lumbar muestra pleocitosis, proteínas elevadas y glucosa baja; Gram pendiente. No hay contraindicación para neuroimagen urgente antes de antibióticos. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál principio terapéutico es correcto?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Administrar antibióticos empíricos con penetración a LCR de inmediato tras cultivos, ajustando a resultado y duración para meningitis. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La sospecha de meningitis neonatal exige tratamiento inmediato; no debe esperarse cultivo final ni retrasarse por estudios no esenciales en un neonato estable. El esquema se ajusta a patógenos y sensibilidad.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de sepsis y meningitis neonatal.

Especialidad: Pediatría**Tema: Vacunación****Subtema: Anafilaxia posterior a vacuna**

Caso clínico 79. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Lactante de 7 meses desarrolla urticaria generalizada, sibilancias, estridor y hipotensión minutos después de vacunación. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: No tiene fiebre ni antecedentes de asma. Se encuentra en unidad de salud con adrenalina intramuscular disponible. Se propone dar antihistamínico oral y observar. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es la intervención de primera línea?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Adrenalina intramuscular en muslo anterolateral, soporte de vía aérea/circulación y referencia para observación. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La anafilaxia se trata con adrenalina IM de inmediato; antihistamínicos no resuelven compromiso respiratorio o choque. Debe documentarse evento y valorar componentes vacunales antes de futuras dosis.

Fuente: Secretaría de Salud. Manual de vacunación universal vigente.

Especialidad: Pediatría**Tema: Crecimiento y desarrollo****Subtema: Muerte súbita del lactante - prevención**

Caso clínico 80. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Padres de lactante sano de 2 meses preguntan cómo reducir riesgo de muerte súbita; duermen al niño en cama compartida, boca abajo, con almohadas. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: No hay exposición prenatal conocida, pero padre fuma dentro del domicilio. El niño recibe lactancia mixta y no tiene enfermedad respiratoria actual. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál recomendación es prioritaria?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Dormir siempre en decúbito supino sobre superficie firme, sin objetos blandos ni humo, idealmente en la misma habitación pero no en la misma cama. *

Explicación: La posición supina y un entorno de sueño seguro reducen de manera consistente muerte súbita. El colecho en condiciones inseguras, almohadas y humo incrementan riesgo; no se recomienda posición prona para prevenir reflujo en lactante sano.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Prevención de muerte súbita del lactante.

Especialidad: Cirugía General**Tema: Introducción a cirugía y cirugía abdominal****Subtema: Abdomen agudo con peritonitis**

Caso clínico 81. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 66 años con dolor abdominal que inició epigástrico y se volvió difuso, rigidez involuntaria y fiebre.

Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: TA 94/58 mmHg, FC 118 lpm, lactato elevado. Radiografía de tórax muestra aire subdiafragmático. Tiene uso crónico de AINE y no hay antecedente de cirugía abdominal reciente. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta inicial es correcta?

A. Reanimación, antibióticos de amplio espectro, ayuno, sonda nasogástrica según caso y valoración quirúrgica urgente para control de fuente. *

B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La perforación de víscera hueca con peritonitis y choque es una urgencia de control de fuente. Los estudios adicionales no deben retrasar estabilización y cirugía; los inhibidores de bomba por sí solos son insuficientes.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento del abdomen agudo quirúrgico.

Especialidad: Cirugía General**Tema: Patología esofágica****Subtema: Acalasia**

Caso clínico 82. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 42 años con disfagia progresiva tanto a sólidos como líquidos, regurgitación nocturna y pérdida de peso. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Endoscopia descarta lesión obstructiva; esofagograma muestra dilatación y afilamiento distal en 'pico de ave'. Manometría de alta resolución muestra aperistalsis y falta de relajación del EEI. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento definitivo debe discutirse?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Miotomía de Heller laparoscópica con funduplicatura parcial o POEM según experiencia y características del caso. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La manometría confirma acalasia. El objetivo es disminuir resistencia del EEI; dilatación neumática, Heller o POEM son alternativas, y la elección se individualiza. Los procinéticos no resuelven la obstrucción funcional.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de acalasia.

Especialidad: Cirugía General

Tema: Patología gástrica

Subtema: Úlcera péptica perforada

Caso clínico 83. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 54 años con dolor epigástrico súbito 'en puñalada' de seis horas, abdomen en tabla y neumoperitoneo. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Usa naproxeno diariamente, no tiene cirrosis. Tras cristaloides sigue con taquicardia, pero responde. No hay absceso contenido ni diagnóstico alterno. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo indicado?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Intervención quirúrgica urgente para cierre de perforación y lavado, más antibióticos e inhibidor de bomba de protones. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La perforación libre causa peritonitis química y bacteriana y generalmente requiere control quirúrgico. El tratamiento de *H. pylori* y suspensión de AINE forman parte del manejo posterior, no sustituyen control inicial.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de enfermedad ácido péptica complicada.

Especialidad: Cirugía General

Tema: Patología biliar

Subtema: Colecistitis aguda litiásica

Caso clínico 84. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 39 años con dolor en hipocondrio derecho de 18 horas, fiebre, náusea y signo de Murphy positivo. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Leucocitos 14,000/ μ L; ultrasonido: litos, engrosamiento vesicular y líquido perivesicular, sin dilatación de colédoco. Está estable y no hay pancreatitis. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál manejo definitivo se recomienda durante este ingreso?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Colecistectomía laparoscópica temprana, después de soporte, analgesia y antibiótico cuando esté indicado. *

Explicación: La colecistectomía temprana reduce recurrencias y estancias frente a diferirla de rutina.

La clínica y ultrasonido confirman colecistitis; no se requiere CPRE sin sospecha de coledocolitiasis.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de colecistitis aguda litiásica.

Especialidad: Cirugía General**Tema: Patología biliar****Subtema: Colangitis aguda**

Caso clínico 85. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 72 años con fiebre, ictericia, dolor en hipocondrio derecho, hipotensión y confusión. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Bilirrubina directa elevada, FA alta, leucocitosis y ultrasonido con colédoco dilatado y lito distal. Tras líquidos sigue hipotenso; se inician antibióticos. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso de control de fuente?

- A. Drenaje biliar urgente, preferentemente por CPRE, además de reanimación y antibióticos. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La pentada de Reynolds indica colangitis grave con sepsis. Los antibióticos sin descompresión pueden fracasar ante obstrucción persistente; la CPRE permite drenaje y manejo del cálculo.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de colangitis aguda.

Especialidad: Cirugía General

Tema: Patología pancreática

Subtema: Pancreatitis aguda biliar

Caso clínico 86. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 46 años con dolor epigástrico irradiado a espalda, lipasa tres veces límite superior y vómitos. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene litos vesiculares, sin colangitis, sin ictericia persistente y sin falla orgánica. Hematocrito y BUN se vigilan; tomografía inicial no muestra necrosis y no hay indicación de antibiótico profiláctico. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo inicial más apropiado?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Reanimación con cristaloides balanceado guiada por respuesta, analgesia y alimentación enteral/oral temprana conforme tolerancia. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La pancreatitis leve se maneja de soporte; la nutrición temprana reduce complicaciones frente a ayuno prolongado. CPRE urgente se reserva para colangitis u obstrucción biliar persistente, no para todo origen biliar.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de pancreatitis aguda.

Especialidad: Cirugía General**Tema: Apendicitis****Subtema: Apendicitis aguda no complicada**

Caso clínico 87. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Varón de 21 años con migración de dolor periumbilical a fosa iliaca derecha, anorexia y náusea. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene defensa localizada, leucocitosis y PCR elevada. Ultrasonido no concluyente; tomografía confirma apéndice dilatado sin absceso, flemón ni perforación. Está estable y en ayuno. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento definitivo estándar es apropiado?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Apendicectomía laparoscópica temprana con antibiótico perioperatorio. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La apendicitis confirmada no complicada se resuelve de forma definitiva con apendicectomía, preferentemente laparoscópica donde se dispone. El tratamiento antibiótico aislado puede seleccionarse en casos específicos, pero exige discusión de recurrencia.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de apendicitis aguda.

Especialidad: Cirugía General**Tema: Patología diverticular****Subtema: Diverticulitis aguda complicada**

Caso clínico 88. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 63 años con dolor en fosa ilíaca izquierda, fiebre y leucocitosis; no tiene peritonitis difusa. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tomografía: diverticulitis sigmoidea con absceso pericólico de 5 cm, sin aire libre. Está estable y responde a líquidos. No hay inmunosupresión. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál manejo es el más apropiado?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Antibióticos y drenaje percutáneo del absceso si es accesible, con cirugía si falla o hay peritonitis. *

Explicación: El absceso grande es una complicación que suele requerir drenaje además de antibióticos.

La operación urgente se reserva para perforación libre, peritonitis o fracaso; no debe tratarse como diverticulitis no complicada ambulatoria.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de enfermedad diverticular del colon.

Especialidad: Cirugía General

Tema: Patología intestinal quirúrgica

Subtema: Obstrucción intestinal por adherencias

Caso clínico 89. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 58 años con antecedente de histerectomía abierta, dolor cólico, distensión, vómito bilioso y ausencia de flatos. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tomografía muestra asas de intestino delgado dilatadas con punto de transición, sin neumatosis, isquemia ni hernia encarcelada. Lactato normal y exploración sin peritonismo. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta inicial?

- A. Manejo no operatorio vigilado con ayuno, descompresión nasogástrica, líquidos/electrolitos y reevaluación estrecha. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: En obstrucción adhesiva sin signos de estrangulación o peritonitis, la prueba conservadora es apropiada. Deterioro clínico, isquemia o falta de resolución obligan a cirugía; laxantes están contraindicados.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de obstrucción intestinal.

Especialidad: Cirugía General**Tema: Patología isquémica intestinal****Subtema: Isquemia mesentérica aguda**

Caso clínico 90. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 76 años con fibrilación auricular sin anticoagulación, dolor abdominal intenso de inicio súbito desproporcionado al examen. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene lactato 4 mmol/L y acidosis metabólica, pero abdomen inicialmente blando. Angio-TC muestra oclusión de arteria mesentérica superior sin infarto transmural inequívoco. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál estrategia debe iniciarse?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Reanimación, anticoagulación con heparina si no está contraindicada y revascularización urgente/endovascular o quirúrgica según anatomía y peritonitis. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El dolor desproporcionado y FA sugieren embolia mesentérica. El tiempo determina viabilidad intestinal; esperar peritonitis significa infarto avanzado. La angio-TC confirma y orienta revascularización.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de isquemia mesentérica aguda.

Especialidad: Cirugía General**Tema: Hernias y esplenectomía****Subtema: Hernia inguinal incarcerada**

Caso clínico 91. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 70 años con masa inguinal dolorosa irreducible de 12 horas, náusea y vómitos. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: La piel está eritematosa, no expulsa gases y tiene taquicardia; lactato elevado. Tomografía muestra asa intestinal en saco herniario con engrosamiento y líquido, sin reducción espontánea. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta es indicada?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Exploración quirúrgica urgente y reparación de hernia con evaluación de viabilidad intestinal.
- *
D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: Hay datos de estrangulación y obstrucción, por lo que la reducción forzada en urgencias puede ocultar intestino isquémico. La cirugía permite control del contenido y resección si existe necrosis.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de hernia inguinal del adulto.

Especialidad: Cirugía General

Tema: Patología intestinal inflamatoria

Subtema: Colitis ulcerosa aguda grave

Caso clínico 92. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 27 años con colitis ulcerosa conocida, seis evacuaciones sanguinolentas al día, fiebre, taquicardia y Hb 9 g/dL. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: PCR elevada, radiografía sin megacolon tóxico, coprocultivo y C. difficile en proceso. Está hospitalizado y no hay perforación. Ha fallado 5-ASA ambulatorio. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento inicial hospitalario?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Corticosteroide intravenoso, profilaxis tromboembólica y evaluación de respuesta precoz para terapia de rescate/cirugía. *

Explicación: La colitis aguda grave requiere hospitalización y esteroides IV tras excluir infección relevante. Debe vigilarse respuesta en pocos días; retrasar rescate o colectomía ante deterioro o aumento de complicaciones.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de colitis ulcerosa crónica idiopática.

Especialidad: Cirugía General

Tema: Patología hepática

Subtema: Hepatitis B crónica

Caso clínico 93. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 35 años con HBsAg positivo por más de 12 meses, HBeAg positivo, DNA-VHB alto y ALT persistentemente elevada. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Elastografía sugiere fibrosis significativa; serologías para VIH y VHC negativas. No hay descompensación ni carcinoma. Pregunta si debe tomar 'hepatoprotectores' sin antiviral. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento de primera línea debe considerarse?

A. Análogo nucleós(t)ido de alta barrera genética, como tenofovir o entecavir, con seguimiento especializado. *

B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La actividad viral, ALT elevada y fibrosis sustentan tratamiento antiviral. Los fármacos de alta barrera suprimen replicación y reducen progresión; interferón y otras opciones se individualizan, pero suplementos no son tratamiento.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de hepatitis B crónica.

Especialidad: Cirugía General**Tema: Cirrosis y complicaciones****Subtema: Hemorragia por várices esofágicas**

Caso clínico 94. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 54 años con cirrosis alcohólica llega con hematemesis abundante, melena y TA 88/54 mmHg. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene ascitis y plaquetas 70,000/ μ L. Se protege vía aérea por hematemesis continua; inicia reanimación restrictiva. No hay datos de perforación abdominal. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál paquete específico debe implementarse temprano?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Fármaco vasoactivo, antibiótico profiláctico y endoscopia terapéutica urgente con ligadura de várices tras estabilización. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El sangrado variceal necesita manejo combinado: vasoactivo reduce presión portal, antibiótico disminuye infecciones/mortalidad y ligadura controla fuente. La reposición excesiva puede aumentar presión portal y resangrado.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de hemorragia por várices esofágicas.

Especialidad: Cirugía General

Tema: Patología arterial y venosa

Subtema: Tromboembolia pulmonar de alto riesgo

Caso clínico 95. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 63 años, posoperatorio reciente de cadera, presenta disnea súbita, síncope, hipotensión persistente y SatO₂ 82%. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Ecocardiograma a pie de cama revela sobrecarga de ventrículo derecho; angio-TC confirma tromboembolismo pulmonar central. No tiene hemorragia activa ni antecedente de evento intracraneal. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál reperfusión debe considerarse?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Trombólisis sistémica si no hay contraindicaciones, junto con soporte hemodinámico y anticoagulación según protocolo. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La hipotensión por TEP define alto riesgo y requiere reperfusión urgente. La anticoagulación aislada puede ser insuficiente; contraindicaciones de trombólisis deben evaluarse de manera explícita.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de tromboembolia pulmonar aguda.

Especialidad: Cirugía General**Tema: Patología perianal****Subtema: Absceso anorrectal**

Caso clínico 96. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 36 años con dolor perianal pulsátil, fiebre y masa fluctuante dolorosa cercana al margen anal. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene diabetes mal controlada, pero no neutropenia. TAC no muestra extensión supralevariana. No hay datos de gangrena de Fournier. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento es fundamental?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Incisión y drenaje oportuno del absceso, con antibióticos selectivos por diabetes/celulitis o infección sistémica. *

Explicación: El drenaje es el tratamiento definitivo de un absceso; antibióticos solos no resuelven colección. Debe vigilarse evolución y fístula posterior, especialmente en abscesos complejos o recurrencia.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de absceso y fístula anorrectal.

Especialidad: Cirugía General

Tema: Urología

Subtema: Cólico renal complicado

Caso clínico 97. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 32 años con dolor lumbar, fiebre de 39°C, escalofríos y disuria; TAC muestra cálculo ureteral proximal de 8 mm con hidronefrosis. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: TA 96/60 mmHg, FC 120 lpm, creatinina en ascenso y piuria. Responde parcialmente a líquidos y recibe antibióticos. Pregunta si puede expulsarlo con alfa-bloqueador en casa. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta es urgente?

A. Descompresión del sistema urinario infectado mediante catéter ureteral o nefrostomía, además de antibióticos. *

B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: Obstrucción urinaria con infección y sepsis es urgencia urológica. Los antibióticos penetran mal en sistema obstruido; expulsión médica y litotricia se diferir hasta resolver sepsis.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de litiasis urinaria.

Especialidad: Cirugía General**Tema: ETS****Subtema: Sífilis primaria**

Caso clínico 98. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 29 años con úlcera genital única, indolora, de base limpia y adenopatía inguinal no dolorosa. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Refiere relación sexual sin barrera hace tres semanas. Prueba treponémica reactiva y VDRL 1:32; no presenta síntomas neurológicos u oculares. Estado de VIH aún en estudio. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento es de elección?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Penicilina G benzatínica intramuscular en dosis adecuada para sífilis temprana, con seguimiento serológico y manejo de parejas. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La lesión y serología son compatibles con sífilis primaria. Penicilina benzatínica es tratamiento estándar; se debe advertir reacción de Jarisch-Herxheimer y asegurar pruebas/atención de otras ITS.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de sífilis adquirida.

Especialidad: Cirugía General**Tema: ATLS****Subtema: Trauma torácico - neumotórax a tensión**

Caso clínico 99. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Varón de 28 años politraumatizado, con disnea extrema, hipotensión, desviación traqueal y ausencia de murmullo vesicular izquierdo. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene ingurgitación yugular y deterioro rápido tras lesión por objeto punzocortante. No se espera radiografía y el equipo prepara intubación. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál intervención debe realizarse de inmediato?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Descompresión torácica de emergencia seguida de colocación de tubo pleural. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El diagnóstico de neumotórax a tensión es clínico y su tratamiento no espera imagen.

Intubar antes de descomprimir puede precipitar colapso cardiovascular por aumento de presión intratorácica.

Fuente: Secretaría de Salud/CENETEC. Guía de Práctica Clínica: Atención inicial del paciente politraumatizado.

Especialidad: Cirugía General**Tema: Intoxicaciones y picaduras****Subtema: Alacranismo grave**

Caso clínico 100. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Niño de 6 años de zona endémica, picado por alacrán hace una hora, con sialorrea profusa, nistagmo, diaforesis y taquicardia. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Está ansioso, sin antecedente de alergia. No hay mordedura de serpiente ni exposición a organofosforados. El centro cuenta con faboterápico polivalente específico. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento específico es indicado?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Administrar faboterápico antialacrán temprano, además de soporte y vigilancia cardiorrespiratoria. *

Explicación: Los signos autonómicos y neurológicos indican envenenamiento clínicamente relevante. El faboterápico neutraliza veneno y es más efectivo temprano; analgésicos aislados no previenen complicaciones sistémicas.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de intoxicación por picadura de alacrán.

Especialidad: Cirugía General**Tema: Quemaduras, golpe de calor e hipotermia****Subtema: Quemadura térmica extensa**

Caso clínico 101. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Adulto de 34 años con quemadura por flama de espesor parcial/profundo en tronco y ambas extremidades superiores, estimada 28% SCT. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Ocurrió hace una hora en espacio cerrado; tiene cejas chamuscadas y esputo carbonáceo. TA estable inicialmente, pero presenta ronquera progresiva. Peso 70 kg. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál prioridad es correcta?

- A. Asegurar vía aérea tempranamente por posible lesión inhalatoria e iniciar reanimación con líquidos guiada por fórmula y respuesta clínica. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La lesión inhalatoria puede evolucionar a edema que dificulte intubación. Quemadura mayor requiere reanimación y traslado a centro especializado; no se deben aplicar antibióticos sistémicos profilácticos de rutina.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de quemaduras.

Especialidad: Cirugía General

Tema: Cirugía oncológica

Subtema: Cáncer de colon obstructivo

Caso clínico 102. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 67 años con pérdida de peso, anemia ferropénica y obstrucción colónica izquierda progresiva. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tomografía muestra lesión estenosante en sigmoidees, dilatación proximal y sin perforación; CEA elevado. Está estable, sin peritonitis, y no se ha realizado colonoscopia completa por obstrucción. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál principio oncológico debe guiar tratamiento?

A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

B. Resección oncológica con márgenes y linfadenectomía adecuada, individualizando descompresión/stent puente según experiencia y estabilidad. *

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La obstrucción no elimina principios de resección oncológica. El manejo debe balancear urgencia, posibilidad de anastomosis y estadio; una derivación sin plan oncológico no es tratamiento definitivo en paciente apto.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de cáncer de colon y recto.

Especialidad: Cirugía General**Tema: Oftalmología****Subtema: Glaucoma agudo de ángulo cerrado**

Caso clínico 103. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 66 años con dolor ocular intenso, ojo rojo, visión de halos, cefalea y vómito. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Pupila media dilatada poco reactiva, córnea edematosa y presión intraocular 52 mmHg. No hay trauma ni exposición química. Se considera migraña por el vómito. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál manejo inicial es correcto?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Reducir presión intraocular con tratamiento farmacológico urgente y realizar iridotomía láser definitiva cuando la córnea lo permita. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El glaucoma agudo amenaza visión en horas. La clínica es ocular y no debe atribuirse a cefalea primaria; después de bajar presión se trata el bloqueo pupilar, y se evalúa el ojo contralateral.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de glaucoma primario de ángulo cerrado.

Especialidad: Cirugía General

Tema: Otorrinolaringología

Subtema: Otitis externa maligna

Caso clínico 104. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 72 años con diabetes mal controlada, otalgia intensa nocturna y otorrea persistente pese a gotas habituales. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Exploración revela tejido de granulación en unión osteocartilaginosa; VSG elevada y TAC sugiere compromiso de base de cráneo. No tiene parálisis facial aún. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta es indicada?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Hospitalizar o manejar estrechamente con antibiótico sistémico antipseudomónico y valoración otorrinolaringológica urgente. *

Explicación: La otitis externa necrosante en diabético puede progresar a osteomielitis de base de cráneo y pares craneales. Las gotas simples no son suficientes; se requiere control metabólico y tratamiento prolongado dirigido.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de otitis externa maligna.

Especialidad: Cirugía General

Tema: Traumatología y ortopedia

Subtema: Síndrome compartimental agudo

Caso clínico 105. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Varón de 25 años con fractura diafisaria de tibia tratada con férula, desarrolla dolor creciente desproporcionado a las seis horas. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: El dolor aumenta con estiramiento pasivo de dedos; tiene parestesias, compartimento tenso y pulsos pedios presentes. Recibió opioides repetidos sin alivio. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo correcto?

- A. Retirar compresión externa y realizar fasciotomía urgente si la sospecha clínica es alta, sin esperar pérdida de pulso. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: Los pulsos pueden persistir hasta fase tardía. El dolor a estiramiento y tensión compartimental obligan a descompresión rápida; retraso causa necrosis muscular, contractura y falla renal.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de síndrome compartimental agudo.

Especialidad: Cirugía General

Tema: Patología pancreática

Subtema: Pancreatitis necrosante infectada

Caso clínico 106. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 51 años con pancreatitis grave, día 18 de hospitalización, fiebre recurrente, leucocitosis y deterioro tras mejoría inicial. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: TC contrastada muestra necrosis organizada con burbujas de gas; hemocultivos se toman. Está estable con soporte, sin peritonitis; se debate necrosectomía abierta inmediata. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál estrategia se prefiere?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Antibióticos dirigidos y enfoque escalonado, posponiendo/interviniendo con drenaje percutáneo o endoscópico cuando sea posible. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La necrosis infectada suele requerir intervención, pero diferir y usar estrategia step-up reduce morbilidad frente a necrosectomía abierta temprana. El gas sugiere infección, no mera inflamación estéril.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de pancreatitis aguda grave.

Especialidad: Cirugía General

Tema: Patología intestinal quirúrgica

Subtema: Vólvulo de sigmoides

Caso clínico 107. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 74 años institucionalizado, con estreñimiento crónico, distensión masiva y dolor abdominal progresivo.

Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Radiografía muestra signo de 'grano de café'; tomografía confirma torsión sigmoidea sin isquemia, perforación ni peritonitis. Está hemodinámicamente estable. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo inicial?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Descompresión endoscópica y colocación de sonda rectal, seguida de resección sigmoidea electiva para prevenir recurrencia. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: Sin isquemia/perforación, la reducción endoscópica es inicial. Sin embargo, la recurrencia es elevada si no se realiza tratamiento definitivo; cirugía inmediata corresponde a peritonitis, perforación o falla endoscópica.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de vólvulo de colon.

Especialidad: Cirugía General**Tema: Cirrosis y complicaciones****Subtema: Peritonitis bacteriana espontánea**

Caso clínico 108. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 58 años con cirrosis descompensada, ascitis y confusión nueva, sin dolor abdominal intenso. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Paracentesis muestra 420 PMN/mm³; creatinina 1.6 mg/dL y bilirrubina 5 mg/dL. No hay foco quirúrgico en TAC. Cultivo se toma en frascos de hemocultivo a pie de cama. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento debe iniciarse?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Cefalosporina de tercera generación y albúmina intravenosa en paciente con alto riesgo renal, sin esperar cultivo. *

Explicación: PMN ascítico $\geq 250/\text{mm}^3$ confirma PBE y obliga a antibiótico precoz. La albúmina reduce síndrome hepatorenal en pacientes seleccionados; no debe buscarse cirugía si no hay peritonitis secundaria.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de peritonitis bacteriana espontánea.

Especialidad: Cirugía General

Tema: Patología arterial y venosa

Subtema: Isquemia aguda de extremidad

Caso clínico 109. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 69 años con fibrilación auricular, dolor súbito de pierna izquierda, palidez, frialdad y ausencia de pulsos distales. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene parestesias leves, pero conserva movilidad. Doppler sugiere oclusión arterial femoral. No hay sangrado activo ni contraindicación a anticoagulación. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta inicial es indicada?

- A. Heparina no fraccionada inmediata y evaluación urgente por cirugía vascular para revascularización según viabilidad. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: Las seis P sugieren isquemia aguda; heparina evita propagación mientras se decide embolectomía/trombólisis. Déficit motor o anestesia indican amenaza extrema y hacen el tiempo aún más crítico.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de isquemia aguda de extremidades.

Especialidad: Cirugía General**Tema: Urología****Subtema: Retención urinaria por hiperplasia prostática**

Caso clínico 110. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 74 años con imposibilidad total para orinar, dolor suprapúbico y globo vesical. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Antecedente de síntomas urinarios bajos progresivos, sin fiebre, hematuria masiva ni déficit neurológico. Creatinina normal; tacto rectal con próstata aumentada, lisa y no dolorosa. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el primer paso?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Descompresión vesical con cateterismo uretral y evaluación subsecuente de HBP/causas de retención. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La retención aguda exige aliviar obstrucción y vigilar diuresis posobstructiva.

Antagonistas alfa y estudio prostático se consideran después; no se debe iniciar sólo fármacos sin descomprimir vejiga dolorosa.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de hiperplasia prostática benigna.

Especialidad: Cirugía General

Tema: ATLS

Subtema: Trauma craneoencefálico grave

Caso clínico 111. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Varón de 19 años tras choque, Glasgow 7, anisocoria progresiva y vómito; presión arterial mantenida. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: TAC: hematoma subdural agudo de 12 mm con desviación de línea media 8 mm. Se aseguran medidas de ABC y no hay lesión cervical descartada aún. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta es apropiada?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Intubación con protección cervical, medidas para evitar hipoxia/hipotensión y neurocirugía urgente para evacuación. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: TCE grave con hematoma y efecto de masa requiere control de vía aérea y descompresión neuroquirúrgica. La hiperventilación intensa prolongada y la hipotensión agravan lesión cerebral secundaria.

Fuente: Secretaría de Salud/CENETEC. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de trauma craneoencefálico en el adulto.

Especialidad: Cirugía General

Tema: Intoxicaciones y picaduras

Subtema: Mordedura de serpiente venenosa

Caso clínico 112. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Trabajador rural de 30 años con mordedura en pierna, edema progresivo, equimosis y sangrado gingival tras dos horas. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene dolor intenso, TP prolongado y plaquetas bajas. No usó torniquete, pero compañero propone incisión y succión. Centro cuenta con faboterápico antiviperino. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál manejo específico se indica?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Faboterápico antiviperino según gravedad, inmovilización y vigilancia/coagulación seriada; evitar incisión, succión y torniquetes. *

Explicación: El síndrome local progresivo y coagulopatía indican envenenamiento sistémico. El antiveneno neutraliza toxina; prácticas locales retrasan atención y ocasionan lesión adicional.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de intoxicación por mordedura de serpiente.

Especialidad: Cirugía General

Tema: Cirugía oncológica

Subtema: Cáncer gástrico resecable

Caso clínico 113. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 60 años con anemia, plenitud posprandial y biopsia de adenocarcinoma gástrico distal. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tomografía sin metástasis; ecoendoscopia sugiere cT3N+. Laparoscopia de estadificación sin carcinomatosis ni citología positiva. Estado funcional adecuado. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál estrategia debe discutirse en equipo multidisciplinario?

A. Quimioterapia perioperatoria seguida de gastrectomía oncológica con linfadenectomía adecuada, según estadio y factibilidad. *

B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: En enfermedad localmente avanzada resecable, el tratamiento perioperatorio mejora control sistémico en pacientes seleccionados. La extensión de resección y ganglios debe seguir principios oncológicos, no sólo paliar síntomas.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de cáncer gástrico.

Especialidad: Cirugía General

Tema: Oftalmología

Subtema: Desprendimiento de retina regmatógeno

Caso clínico 114. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer miope de 55 años refiere fotopsias, aumento de moscas volantes y 'cortina' que progresa desde periferia.

Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Agudeza visual central aún conservada; fondo de ojo sugiere desprendimiento temporal con mácula aplicada. No hubo trauma reciente ni dolor ocular. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta es indicada?

A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

B. Referencia oftalmológica urgente para reparación de retina; instruir evitar demoras y traumatismos adicionales. *

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El desprendimiento regmatógeno amenaza visión irreversible cuando compromete mácula. No se trata como migraña ocular ni con gotas; la reparación oportuna busca preservar visión central.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de desprendimiento de retina.

Especialidad: Cirugía General**Tema: Otorrinolaringología****Subtema: Absceso periamigdalino**

Caso clínico 115. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Adulto joven con odinofagia unilateral intensa, voz 'de papa caliente', trismus y desviación de úvula. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene sialorrea moderada, pero no estridor; fiebre 38.8°C y adenopatías dolorosas. No hay rigidez cervical profunda ni compromiso respiratorio inminente. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál manejo es adecuado?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Valoración otorrinolaringológica para drenaje por aspiración/incisión, antibióticos y analgesia, vigilando vía aérea. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El absceso periamigdalino suele requerir drenaje más antibióticos. Sólo tratar como faringitis puede permitir extensión a espacios profundos; la vía aérea se vigila estrechamente.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de absceso periamigdalino.

Especialidad: Cirugía General

Tema: Traumatología y ortopedia

Subtema: Embolia grasa

Caso clínico 116. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Paciente de 23 años con fractura bilateral de fémur, 30 horas después desarrolla disnea, confusión y petequias en tórax superior. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: SatO2 84%, plaquetas disminuidas y radiografía con infiltrados bilaterales difusos. No hay datos de trombosis venosa documentada ni traumatismo craneal que explique el deterioro. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento principal?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Soporte respiratorio y hemodinámico, inmovilización/fijación oportuna de fracturas y exclusión de diagnósticos alternos. *

Explicación: El síndrome de embolia grasa es clínico y no tiene antídoto específico. La atención se centra en oxigenación y soporte; anticoagulación o trombólisis no son tratamiento de esta entidad.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de trauma ortopédico.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Introducción e infectología

Subtema: Choque séptico

Caso clínico 117. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 68 años con pielonefritis obstructiva, fiebre, confusión, TA 78/42 mmHg y lactato 5.2 mmol/L. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tras hemocultivos recibe cristaloideos balanceados; persiste hipotenso. Tiene diuresis escasa y no hay hemorragia. Urología está disponible para drenaje de foco. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál vasopresor es de primera línea si continúa hipotensión tras líquidos?

A. Norepinefrina, mientras se completa control de fuente y antimicrobianos de amplio espectro tempranos. *

B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El choque séptico requiere reanimación, antibióticos y control de fuente sin demora.

Norepinefrina es vasopresor inicial; la presión arterial no debe sostenerse con líquidos ilimitados si hay falta de respuesta.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de sepsis y choque séptico.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Infecciones específicas

Subtema: Tuberculosis pulmonar

Caso clínico 118. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 38 años con tos de seis semanas, pérdida de peso, diaforesis nocturna y contacto domiciliario con TB.

Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Radiografía con cavitación apical; prueba molecular en esputo detecta M. tuberculosis sin resistencia a rifampicina. No tiene hepatopatía ni VIH conocido; vive con dos niños pequeños. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el manejo inicial adecuado?

A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

B. Iniciar esquema antituberculoso de primera línea conforme a programa, notificar, estudiar contactos y asegurar adherencia supervisada. *

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La prueba molecular confirma TB sensible a rifampicina y permite iniciar tratamiento sin esperar cultivo. La atención incluye salud pública, evaluación de VIH y contactos; monoterapia favorece resistencia.

Fuente: Secretaría de Salud. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de tuberculosis pulmonar.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Infecciones específicas

Subtema: Dengue con signos de alarma

Caso clínico 119. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 27 años, día 4 de fiebre, ahora con dolor abdominal intenso, vómitos persistentes y mareo al ponerse de pie. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene hemoconcentración progresiva, plaquetas 78,000/ μ L y derrame pleural pequeño. No hay sangrado masivo; prueba NS1 fue positiva. Vive en zona con brote. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es la conducta correcta?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Hospitalización y reposición cuidadosa con cristaloideos isotónicos guiada por perfusión, hematocrito y signos de fuga plasmática. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: Dolor abdominal, vómitos y hemoconcentración son signos de alarma, frecuentemente al entrar en fase crítica. AINE y procedimientos invasivos innecesarios aumentan riesgo hemorrágico; líquidos requieren titulación, no sobrecarga.

Fuente: Secretaría de Salud. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de dengue.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Neumología

Subtema: Exacerbación de EPOC

Caso clínico 120. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 70 años con EPOC, aumento de disnea, volumen y purulencia de esputo desde hace dos días. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: SatO₂ 84%, pH 7.29, PaCO₂ 68 mmHg, consciente y cooperador; radiografía sin neumonía. No hay contraindicación para ventilación no invasiva. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál intervención ventilatoria está indicada?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Oxígeno titulado a meta segura y ventilación no invasiva con presión positiva, junto con broncodilatadores, esteroide y antibiótico cuando corresponde. *

Explicación: La acidosis respiratoria hipercápnica en exacerbación responde a VNI y reduce intubación.

Oxígeno sin titulación puede agravar hipercapnia; intubación se reserva para falla de VNI o deterioro.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Cetoacidosis diabética

Caso clínico 121. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 22 años con diabetes tipo 1, poliuria, vómitos, respiración de Kussmaul y dolor abdominal. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Glucosa 480 mg/dL, pH 7.08, bicarbonato 8 mEq/L, anión gap elevado y potasio 3.1 mEq/L. Está deshidratada, sin infección evidente. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál corrección debe realizarse antes de iniciar insulina intravenosa?

A. Reposición de potasio hasta nivel seguro, además de líquidos isotónicos y monitorización estrecha. *

B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La insulina desplaza potasio al interior y puede precipitar arritmia si existe hipokalemia marcada. El tratamiento integra volumen, electrolitos, insulina y búsqueda de desencadenante; bicarbonato no es rutinario.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de cetoacidosis diabética.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Hematología

Subtema: Anemia ferropénica con alarma

Caso clínico 122. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 62 años con fatiga, pica y Hb 8.1 g/dL; VCM 70 fL, ferritina baja y saturación de transferrina reducida.

Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: No tiene hematuria ni dieta restrictiva.

Refiere cambio reciente en hábito intestinal y pérdida de 4 kg. No hay sangrado visible; prueba de sangre oculta es positiva. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál estudio etiológico debe priorizarse?

A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

B. Evaluación endoscópica gastrointestinal, incluida colonoscopia, para buscar fuente de pérdida y neoplasia. *

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La deficiencia de hierro en hombre adulto debe considerarse pérdida gastrointestinal hasta demostrar lo contrario. Administrar hierro sin investigar puede retrasar diagnóstico de cáncer colorrectal.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de anemia por deficiencia de hierro.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Cardiología

Subtema: Infarto con elevación de ST

Caso clínico 123. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 58 años con dolor torácico opresivo de 90 minutos, diaforesis y elevación de ST en II, III y aVF. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Está en hospital con sala de hemodinamia disponible y tiempo estimado puerta-balón de 60 minutos. TA 100/64 mmHg, no hay contraindicación a antiagregación. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál estrategia de reperfusión es preferida?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Intervención coronaria percutánea primaria inmediata con terapia antitrombótica apropiada. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: Con capacidad de ICP dentro del tiempo recomendado, ésta es la reperfusión preferida. No se debe retrasar por biomarcadores si ECG es diagnóstico; fibrinólisis se considera cuando ICP oportuna no es posible y no hay contraindicaciones.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de infarto agudo de miocardio con elevación de ST.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Neurología

Subtema: EVC isquémico agudo

Caso clínico 124. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 71 años con afasia y hemiparesia derecha de 90 minutos de inicio conocido. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Glucosa 118 mg/dL, TA 170/92 mmHg, NIHSS 15. TAC simple sin hemorragia ni hipodensidad extensa; angio-TC muestra oclusión proximal de arteria cerebral media izquierda. No usa anticoagulantes. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál manejo de perfusión debe activarse?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Trombólisis intravenosa dentro de ventana si es elegible y trombectomía mecánica por oclusión de gran vaso sin demorar traslado a sala. *

Explicación: Tiene déficit incapacitante, imagen sin sangrado y oclusión de gran vaso. Las terapias son complementarias en elegibles; esperar evolución clínica pierde tejido cerebral salvable.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de evento vascular cerebral isquémico agudo.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Dermatología

Subtema: Síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica

Caso clínico 125. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 30 años inicia lamotrigina hace tres semanas y presenta fiebre, lesiones targetoides dolorosas, erosiones orales y desprendimiento epidérmico. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene afectación ocular y 12% de superficie corporal desprendida. No hay datos de infección bacteriana primaria. Se calcula SCORTEN y se solicita valoración oftalmológica. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es la primera medida crítica?

A. Suspendir inmediatamente el fármaco sospechoso y proporcionar soporte en unidad especializada con manejo de líquidos, piel, dolor y mucosas. *

B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La suspensión temprana del desencadenante es la intervención esencial. El manejo es de soporte intensivo semejante a quemaduras, evitando desbridamiento agresivo rutinario y antibióticos profilácticos indiscriminados.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Reumatología

Subtema: Artritis reumatoide temprana

Caso clínico 126. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 42 años con seis meses de dolor e hinchazón simétrica de MCP, IFP y muñecas, rigidez matutina de dos horas. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: PCR elevada, anti-CCP positivo y erosiones incipientes. No está embarazada, pruebas hepáticas normales y no tiene infección crónica activa. Ha usado AINE con alivio incompleto. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál estrategia modifica el curso de enfermedad?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar temprano un FARME, usualmente metotrexato si no hay contraindicación, con seguimiento por reumatología y estrategia a objetivo. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La artritis inflamatoria persistente seropositiva debe tratarse tempranamente para evitar daño estructural. AINE y esteroides son puentes sintomáticos, no sustitutos de un FARME.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de artritis reumatoide.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Nefrología

Subtema: Síndrome nefrítico rápidamente progresivo

Caso clínico 127. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 49 años con hematuria macroscópica, cilindros eritrocitarios, edema, hipertensión y creatinina que sube de 1.0 a 3.4 mg/dL en dos semanas. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene hemoptisis reciente, anemia y anticuerpos anti-MBG positivos. Ecografía muestra riñones de tamaño normal sin obstrucción. No hay sepsis. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento debe iniciarse de urgencia?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Corticosteroide a dosis alta, ciclofosfamida y plasmaféresis, con nefrología urgente. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El síndrome pulmón-riñón por enfermedad anti-MBG puede destruir función renal rápidamente.

La biopsia confirma cuando es posible, pero ante alta sospecha el tratamiento no debe retrasarse.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de glomerulonefritis rápidamente progresiva.

Especialidad: Medicina Interna**Tema: Psiquiatría****Subtema: Delirium tremens**

Caso clínico 128. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 49 años con consumo intenso de alcohol, 72 horas tras internamiento, presenta agitación, temblor, diaforesis, alucinaciones visuales y desorientación. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: TA 168/102 mmHg, FC 128 lpm, fiebre 38.2°C. No hay focalización neurológica, glucosa normal y TAC sin lesión aguda. Tiene antecedente de convulsión de abstinencia. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento es de primera línea?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Benzodiacepinas tituladas según gravedad, tiamina parenteral y corrección de líquidos/electrolitos con monitorización. *

Explicación: El delirium tremens es potencialmente mortal y las benzodiacepinas son tratamiento principal. La tiamina debe administrarse para prevenir Wernicke; antipsicóticos pueden ser coadyuvantes, no sustitutos.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento del síndrome de abstinencia alcohólica.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Geriátría

Subtema: Delirium hipoactivo posoperatorio

Caso clínico 129. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 83 años tras cirugía de cadera, previamente independiente, desarrolla inatención fluctuante, somnolencia y pensamiento desorganizado. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene dolor mal controlado, usa sonda vesical y recibió benzodiacepina nocturna. Saturación, glucosa y hemoglobina se revisan; no hay déficit focal. Familia lo atribuye a 'demencia que apareció'. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál estrategia es fundamental?

A. Buscar y corregir causas precipitantes, aplicar medidas no farmacológicas multicomponente y evitar fármacos delirógenos innecesarios. *

B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El inicio agudo y fluctuante con inatención es delirium, no demencia. El tratamiento es etiológico y preventivo: orientación, sueño, movilidad, hidratación, control de dolor y revisión de medicamentos.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de delirium en el adulto mayor.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Infecciones específicas

Subtema: VIH avanzado con neumonía por *Pneumocystis*

Caso clínico 130. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 34 años sin tratamiento antirretroviral, con disnea subaguda, tos seca, fiebre y SatO₂ 86%. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: CD4 48 células/ μ L, LDH elevada y TC con opacidades en vidrio despolido difusas. Gasometría con PaO₂ 62 mmHg; no hay consolidación lobar ni choque. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento inicial es correcto?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Trimetoprim-sulfametoxazol a dosis alta más corticosteroide adyuvante por hipoxemia, con plan de inicio oportuno de TAR. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La presentación y CD4 sugieren neumonía por *P. jirovecii*. Corticosteroide reduce deterioro respiratorio en hipoxemia significativa; la TAR se programa cuidadosamente, no se omite de manera indefinida.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de infección por VIH en adultos.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Infecciones específicas

Subtema: Paludismo grave

Caso clínico 131. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 31 años regresa de zona endémica con fiebre intermitente, ictericia, confusión y oliguria. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Gota gruesa positiva para *Plasmodium falciparum* con parasitemia alta; glucosa 54 mg/dL, Hb baja y creatinina elevada. Está hipotenso tras evaluación inicial. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento específico debe iniciarse?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Artesunato intravenoso para paludismo grave, junto con corrección de hipoglucemia y soporte en unidad hospitalaria. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: Alteración neurológica, falla renal, anemia e hipoglucemia definen gravedad. El paludismo grave requiere artesunato parenteral y soporte; tratamiento oral ambulatorio es inadecuado.

Fuente: Secretaría de Salud. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de paludismo.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Neumología

Subtema: Derrame pleural parapneumónico complicado

Caso clínico 132. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 52 años con neumonía, fiebre persistente y dolor pleurítico pese a antibiótico inicial. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Ultrasonido muestra derrame loculado; líquido pleural purulento con pH 6.9, glucosa baja y Gram positivo. No hay insuficiencia cardíaca ni cirrosis. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta es indicada?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Drenaje pleural con tubo más antibióticos dirigidos, valorando fibrinolíticos intrapleurales o cirugía según evolución. *

Explicación: Empiema o líquido con pH bajo/glucosa baja requiere drenaje, ya que antibióticos no penetran adecuadamente colección loculada. La toracocentesis diagnóstica aislada no controla el foco.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de derrame pleural parapneumónico.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Tormenta tiroidea

Caso clínico 133. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 36 años con Graves no tratada, fiebre 40°C, agitación, fibrilación auricular rápida e insuficiencia cardíaca tras infección respiratoria. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene bocio difuso y exoftalmos; T4 libre muy elevada. No hay uso reciente de amiodarona. Se toman cultivos, pero el cuadro es clínicamente crítico. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál secuencia farmacológica es correcta?

A. Betabloqueador, tiamida, yodo después de la tiamida, corticosteroide y tratamiento del desencadenante. *

B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La tormenta tiroidea requiere bloqueo simpático, síntesis y liberación hormonal en secuencia. Administrar yodo antes de tiamida puede aportar sustrato; el soporte y tratamiento de infección son simultáneos.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de hipertiroidismo y enfermedad de Graves.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Hematología

Subtema: Púrpura trombocitopénica trombótica

Caso clínico 134. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 39 años con fatiga, petequias, confusión y fiebre baja; Hb 7.9 g/dL, plaquetas 18,000/μL. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Frotis con esquistocitos, LDH elevada, haptoglobina baja y creatinina 1.5 mg/dL. Coagulación normal. No hay diarrea reciente ni sepsis manifiesta. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento no debe esperar el resultado de ADAMTS13?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Plasmaféresis diaria más corticosteroide, con hematología urgente. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La combinación de anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia sugiere PTT, mortal sin plasmaféresis. Coagulación normal ayuda a diferenciar de CID; transfusión plaquetaria se evita salvo hemorragia que amenace vida.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de púrpura trombocitopénica trombótica.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Cardiología

Subtema: Insuficiencia cardiaca aguda con edema pulmonar

Caso clínico 135. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 68 años con cardiopatía isquémica, ortopnea súbita, estertores difusos y edema periférico. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: TA 186/104 mmHg, SatO₂ 85%, piel caliente, sin dolor torácico. Rx con congestión vascular y BNP elevado; creatinina estable. No hay signos de choque cardiogénico. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál manejo inicial es apropiado?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Oxígeno/soporte ventilatorio según necesidad, diurético IV y vasodilatador IV en contexto hipertensivo, con búsqueda de precipitante. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La congestión con hipertensión es perfil 'caliente y húmedo' y responde a descongestión y reducción de poscarga. Inotrópicos se reservan para hipoperfusión/choque y pueden ser dañinos en hipertensión.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de insuficiencia cardiaca aguda.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Cardiología

Subtema: Fibrilación auricular con respuesta rápida

Caso clínico 136. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 74 años con palpitaciones, disnea y FC 160 lpm; ECG con fibrilación auricular. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: TA 78/46 mmHg, diaforesis, confusión y edema pulmonar. No hay evidencia de intoxicación digitálica ni duración conocida que permita cardioversión electiva ambulatoria. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál intervención está indicada?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Cardioversión eléctrica sincronizada inmediata por inestabilidad hemodinámica. *

Explicación: La inestabilidad atribuible a FA exige cardioversión sincronizada urgente. El control farmacológico de frecuencia no debe retrasar reversión en choque, isquemia o edema pulmonar grave.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de fibrilación auricular.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Neurología

Subtema: Hemorragia intracerebral por hipertensión

Caso clínico 137. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 63 años con hipertensión no controlada, cefalea súbita, vómito y hemiparesia izquierda. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: TAC muestra hematoma gangliobasal derecho de 28 mL sin hidrocefalia; TA 220/118 mmHg, INR normal. Está despierto, sin herniación clínica. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál manejo inicial de presión arterial es correcto?

- A. Reducción controlada y temprana de presión arterial con fármacos IV titulables, evitando hipotensión. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La presión severamente elevada puede favorecer expansión del hematoma, pero una caída abrupta compromete perfusión cerebral. Debe manejarse en unidad con neurocirugía/neurología, y se corrigen coagulopatías si existen.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de hemorragia intracerebral espontánea.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Neurología

Subtema: Miastenia gravis - crisis

Caso clínico 138. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 28 años con miastenia gravis presenta disartria, disfagia, debilidad cervical y disnea tras infección respiratoria. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Capacidad vital forzada disminuye progresivamente y no puede contar hasta 20 en una respiración. No hay pupilas anormales ni sensibilidad alterada. Recibió macrólido recientemente. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta es prioritaria?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Vigilancia en UCI con preparación para soporte ventilatorio y tratamiento con inmunoglobulina IV o plasmaféresis. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La crisis miasténica amenaza vía aérea por debilidad bulbar y respiratoria. La espirometría seriada orienta intubación temprana; IVIG/plasmaféresis aceleran recuperación y deben acompañarse de búsqueda de desencadenante.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de miastenia gravis.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Dermatología

Subtema: Melanoma cutáneo

Caso clínico 139. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 51 años con lesión pigmentada en espalda que creció, cambió de color y sangró en seis meses. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Dermatoscopia es altamente sospechosa. No hay adenopatías palpables ni metástasis clínicas. Se propone afeitar la lesión de forma superficial por estética. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál procedimiento diagnóstico inicial es preferido?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Biopsia excisional con márgenes estrechos y profundidad adecuada para determinar Breslow. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La profundidad de Breslow define pronóstico y márgenes posteriores. Una biopsia superficial puede impedir estadificación correcta; la biopsia excisional es preferida cuando la anatomía lo permite.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de melanoma maligno.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Reumatología

Subtema: Lupus eritematoso sistémico con nefritis

Caso clínico 140. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 24 años con artralgias, fotosensibilidad, edema, HTA y orina con proteinuria 2.5 g/día, hematuria y cilindros. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: ANA y anti-dsDNA positivos, complemento bajo, creatinina 1.3 mg/dL. No está embarazada, no hay infección activa. Recibe hidroxicloroquina irregularmente. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál estudio guía tratamiento inmunosupresor?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Biopsia renal para clasificar nefritis lúpica, salvo contraindicación, junto con inicio oportuno de manejo por nefrología/reumatología. *

Explicación: La biopsia clasifica lesión y permite elegir inducción y pronóstico. Proteinuria y sedimento activo reflejan compromiso renal; no debe tratarse sólo con AINE o aumentar esteroide sin definir clase.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de lupus eritematoso sistémico.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Nefrología

Subtema: Síndrome nefrótico

Caso clínico 141. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 57 años con edema generalizado, albúmina 2.1 g/dL, proteinuria 8 g/día e hiperlipidemia. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Creatinina normal, sedimento urinario inactivo, no diabetes conocida y serologías iniciales negativas. Presenta dolor súbito de pantorrilla y ultrasonido confirma TVP. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Qué complicación explica el evento trombotico?

A. Estado de hipercoagulabilidad del síndrome nefrótico por pérdida de anticoagulantes y aumento de factores procoagulantes. *

B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El síndrome nefrótico predispone a TVP/TEP, especialmente con hipoalbuminemia grave.

Requiere anticoagulación según riesgo y estudio etiológico renal; el edema no debe tratarse exclusivamente con diuréticos sin evaluación integral.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de síndrome nefrótico en el adulto.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Psiquiatría

Subtema: Esquizofrenia con riesgo suicida

Caso clínico 142. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 22 años con alucinaciones auditivas de seis meses, delirios persecutorios, aislamiento y abandono universitario. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Refiere voces que le ordenan lesionarse y plan suicida específico. Examen toxicológico negativo, no delirium ni causa médica inmediata; familia no puede garantizar vigilancia continua. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta es indicada?

A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

B. Valoración psiquiátrica urgente y hospitalización para protección, inicio/ajuste de antipsicótico y plan de seguridad integral. *

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El riesgo suicida con psicosis activa requiere contención y tratamiento urgente. No debe manejarse sólo con cita ambulatoria; se evalúan comorbilidades, sustancias y capacidad de apoyo familiar.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de esquizofrenia en adultos.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Geriatría

Subtema: Caídas recurrentes y polifarmacia

Caso clínico 143. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 81 años con dos caídas en tres meses, una con fractura de radio, sin pérdida de conciencia clara. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Usa benzodiacepina, antihipertensivo, anticolinérgico y cinco fármacos más. Presenta hipotensión ortostática, marcha lenta, visión reducida y fuerza de prensión baja; Mini-Cog normal. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál evaluación/intervención tiene mayor rendimiento?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Valoración multifactorial de caídas con revisión y deprescripción de fármacos de riesgo, entrenamiento de fuerza/equilibrio y corrección de factores modificables. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: Las caídas en adulto mayor casi siempre son multifactoriales. La imagen aislada no sustituye evaluar ortostatismo, fármacos, visión, calzado, entorno y marcha; la prevención efectiva combina intervenciones.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Prevención de caídas en el adulto mayor.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Epidemiología

Subtema: Prueba diagnóstica - interpretación de razón de verosimilitud

Caso clínico 144. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. En un brote hospitalario se evalúa una prueba rápida para una infección; prevalencia preprueba en paciente con síndrome compatible es 30%. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: El laboratorio reporta sensibilidad 90%, especificidad 80% y resultado positivo. El equipo quiere afirmar que el paciente 'tiene 90% de probabilidad' porque esa es la sensibilidad. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál interpretación es correcta?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. El resultado positivo aumenta la probabilidad posterior según la razón de verosimilitud positiva y la probabilidad preprueba; sensibilidad no equivale a valor predictivo individual. *

Explicación: La sensibilidad describe desempeño entre enfermos, no probabilidad posprueba. Debe integrarse prevalencia/preprueba y LR+ para estimar probabilidad posterior, evitando interpretación falaz de pruebas diagnósticas.

Fuente: Secretaría de Salud/CENETEC. Guía de Práctica Clínica: Elaboración e interpretación de preguntas clínicas y pruebas diagnósticas.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Infecciones específicas

Subtema: Endocarditis infecciosa

Caso clínico 145. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 56 años con prótesis valvular aórtica, fiebre de dos semanas, soplo nuevo y hemocultivos positivos repetidos para *S. aureus*. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Ecocardiograma transesofágico muestra vegetación móvil y absceso perianular. Tiene bloqueo AV nuevo y datos de insuficiencia cardíaca incipiente. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta es la más adecuada?

- A. Antibióticos IV dirigidos y valoración urgente por equipo de endocarditis/cirugía cardíaca por complicación perianular y trastorno de conducción. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: Prótesis, absceso y bloqueo AV indican infección complicada con alto riesgo. El tratamiento requiere cultivos y antimicrobianos dirigidos, pero la indicación quirúrgica se evalúa de manera urgente; no basta tratamiento oral.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de endocarditis infecciosa.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Neumología

Subtema: Cáncer de pulmón - masa central

Caso clínico 146. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 65 años, fumador de 60 paquetes-año, con hemoptisis, pérdida ponderal y hiponatremia. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tomografía muestra masa hilar derecha con adenopatías mediastinales. No hay diagnóstico histológico; SatO2 y función renal son adecuadas. Se solicita iniciar quimioterapia por imagen sugestiva. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál paso es indispensable antes de tratamiento oncológico?

A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

B. Obtener diagnóstico histológico y estadificación completa con muestra que permita caracterización molecular cuando corresponda. *

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El tratamiento de cáncer pulmonar depende de histología, estadio y biomarcadores. La imagen define sospecha y sitio de biopsia, pero no sustituye tejido; biopsiar la lesión más accesible/avanzada puede optimizar estadificación.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de cáncer de pulmón.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Insuficiencia suprarrenal aguda

Caso clínico 147. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 41 años con vómitos, dolor abdominal, hipotensión refractaria, hiponatremia, hiperpotasemia e hipoglucemia. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene hiperpigmentación y suspendió abruptamente glucocorticoide crónico tras infección gastrointestinal. No hay hemorragia activa ni sepsis evidente; se toman cortisol/ACTH si no retrasan tratamiento. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál manejo debe iniciarse?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Hidrocortisona intravenosa y reposición agresiva de volumen con solución salina, además de corrección de hipoglucemia/descadenante. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La crisis adrenal es diagnóstico clínico de emergencia. Las muestras hormonales son útiles si se obtienen sin demora, pero nunca deben retrasar esteroide y líquidos; mineralocorticoide no es prioridad aguda con dosis altas de hidrocortisona.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de insuficiencia suprarrenal primaria.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Hematología

Subtema: Neutropenia febril

Caso clínico 148. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 48 años con quimioterapia por cáncer de mama, temperatura 38.7°C y malestar general. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Neutrófilos absolutos 180/ μ L, TA estable, sin foco evidente. Se toman hemocultivos de catéter y periférico, función renal y radiografía según clínica. No se debe esperar recuperación de neutrófilos. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento inicial?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Antibiótico empírico IV antipseudomónico de amplio espectro dentro de la primera hora. *

Explicación: La neutropenia febril es urgencia infecciosa; signos inflamatorios pueden ser mínimos. El tiempo al antibiótico afecta desenlaces y se ajusta luego a cultivos, riesgo y evolución.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de neutropenia febril en el adulto con cáncer.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Cardiología

Subtema: Pericarditis aguda con taponamiento

Caso clínico 149. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 44 años con dolor torácico que mejora al sentarse, disnea progresiva y antecedente de neoplasia. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: TA 84/52 mmHg, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos velados y pulso paradójico. Ecocardiograma muestra derrame grande con colapso diastólico de cavidades derechas. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál intervención es urgente?

A. Pericardiocentesis guiada por ecocardiografía para aliviar taponamiento, junto con manejo de causa. *

B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El taponamiento es compromiso hemodinámico por presión pericárdica y no se resuelve sólo con AINE. El ecocardiograma confirma fisiología y guía drenaje; la reposición de volumen es sólo puente.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de pericarditis aguda y derrame pericárdico.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Neurología

Subtema: Síndrome de Guillain-Barré

Caso clínico 150. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 32 años, dos semanas tras diarrea, presenta parestesias y debilidad ascendente simétrica que progresa en 48 horas. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Arreflexia generalizada, paresia facial bilateral y capacidad vital en descenso; LCR con disociación albuminocitológica. No hay nivel sensitivo ni disfunción esfinteriana inicial. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento y vigilancia son apropiados?

A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

B. Ingreso para monitorización respiratoria/autónoma e inmunoglobulina IV o plasmaféresis tempranas. *

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La progresión rápida y compromiso bulbar/respiratorio exigen vigilancia estrecha. IVIG y plasmaféresis son eficaces; corticosteroides aislados no aceleran recuperación y pueden confundir el manejo.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de síndrome de Guillain-Barré.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Dermatología

Subtema: Pénfigo vulgar

Caso clínico 151. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 52 años con erosiones orales dolorosas de meses y ampollas flácidas que dejan erosiones en tórax. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Nikolsky positivo; biopsia perilesional para inmunofluorescencia demuestra depósito intercelular de IgG. No hay exposición a fármacos nuevos ni lesiones en diana. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál principio de manejo es correcto?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Tratamiento inmunosupresor sistémico bajo dermatología, con corticosteroide y ahorrador/rituximab según gravedad, más cuidado de mucosas e infecciones. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El pénfigo vulgar es autoinmune y puede causar pérdida extensa de barrera y desnutrición por dolor oral. El diagnóstico inmunopatológico guía tratamiento; antibióticos tópicos aislados no controlan enfermedad.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de pénfigo vulgar.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Reumatología

Subtema: Arteritis de células gigantes

Caso clínico 152. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 74 años con cefalea temporal nueva, claudicación mandibular, VSG elevada y amaurosis fugaz. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene dolor a palpación de arteria temporal; no hay focalización neurológica. Biopsia temporal puede organizarse en los próximos días, pero la visión amenaza. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál tratamiento debe iniciarse de inmediato?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Glucocorticoide sistémico a dosis alta, sin esperar biopsia, con evaluación oftalmológica y confirmación diagnóstica posterior. *

Explicación: La pérdida visual puede ser irreversible y el tratamiento no debe retrasarse por biopsia.

La histología sigue siendo útil incluso tras inicio cercano de esteroide; se vigilan complicaciones de tratamiento.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de arteritis de células gigantes.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Nefrología

Subtema: Lesión renal aguda por hiperpotasemia

Caso clínico 153. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 68 años con ERC y uso de IECA/espironolactona, llega por debilidad. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Potasio 7.1 mEq/L, ECG con ondas T picudas y ensanchamiento de QRS; creatinina aumentó respecto a basal. Está hemodinámicamente estable y no tiene acidosis extrema. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál es la primera medida para estabilizar membrana cardíaca?

A. Gluconato de calcio intravenoso con monitorización cardíaca, seguido de medidas para desplazar y eliminar potasio. *

B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.

C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.

D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: Con cambios electrocardiográficos, calcio IV estabiliza miocardio de inmediato pero no reduce potasio. Insulina con glucosa, beta-agonista y eliminación renal/dialítica corrigen concentración según contexto.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de hiperpotasemia en el adulto.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Psiquiatría

Subtema: Trastorno depresivo mayor con ideación suicida

Caso clínico 154. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Mujer de 36 años con anhedonia, insomnio, culpa, pérdida de peso y enlentecimiento por dos meses. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Refiere plan detallado de suicidio, acceso a medio letal y tentativa previa; niega manía, intoxicación o psicosis. Vive sola y no puede asegurar restricción de medios. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál manejo es apropiado?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Evaluación urgente de riesgo y hospitalización/contención según inminencia, con plan de seguridad e inicio de tratamiento integral. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La ideación con plan, medios y antecedente eleva riesgo inminente. Un contrato verbal de no suicidio no sustituye evaluación, reducción de acceso a medios, apoyo y tratamiento psiquiátrico.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de depresión en el adulto.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Geriátría

Subtema: Fragilidad

Caso clínico 155. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 79 años con pérdida involuntaria de 7 kg, agotamiento, velocidad de marcha lenta y debilidad de prensión. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Tiene tres enfermedades crónicas estables y toma ocho fármacos. Aún es independiente en actividades básicas, pero ha reducido actividad física y tuvo una hospitalización reciente por neumonía. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál intervención debe formar parte del plan?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Valoración geriátrica integral con ejercicio de resistencia, optimización nutricional, revisión farmacológica y metas centradas en función. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La fragilidad es vulnerable a estresores y puede ser parcialmente reversible. Tratar sólo una enfermedad aislada pierde objetivos funcionales; la valoración integral guía intervenciones multicomponente.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Prevención, diagnóstico y tratamiento de fragilidad en el adulto mayor.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Epidemiología

Subtema: Diseño de estudio para factor de riesgo raro

Caso clínico 156. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Un grupo investiga asociación entre exposición laboral a solvente y un cáncer extremadamente infrecuente; requiere eficiencia y puede identificar casos confirmados en registros oncológicos. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: La exposición puede reconstruirse mediante expedientes industriales. El presupuesto no permite seguir una cohorte de cientos de miles durante años y el desenlace ya ocurrió en numerosos pacientes. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apegue a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Qué diseño es más eficiente?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Estudio de casos y controles, con selección cuidadosa de controles y medición comparable de exposición. *

Explicación: Para enfermedades raras, casos y controles permite estudiar múltiples exposiciones con menor tiempo y costo. No estima incidencia directamente y está expuesto a sesgo de selección/recuerdo, que deben mitigarse.

Fuente: Secretaría de Salud/CENETEC. Guía de Práctica Clínica: Metodología de la investigación epidemiológica.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Infecciones específicas

Subtema: Meningitis bacteriana en adulto

Caso clínico 157. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 58 años con fiebre, rigidez de nuca, confusión y petequias; no hay papiledema ni déficit focal. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Se obtienen hemocultivos y se planea punción lumbar inmediata. Está estable, pero la familia solicita esperar tomografía para 'mayor seguridad'. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál conducta es correcta?

- A. Administrar dexametasona y antibióticos empíricos inmediatamente tras hemocultivos, sin retrasarlos por imagen cuando no está indicada antes de punción. *
- B. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El retraso de antimicrobianos empeora desenlace en meningitis bacteriana. La imagen previa se reserva para factores de riesgo de herniación; aun entonces, antibióticos se dan antes de la tomografía si genera demora.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de meningitis bacteriana aguda en el adulto.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Endocrinología

Subtema: Síndrome hiperosmolar hiperglucémico

Caso clínico 158. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 76 años con diabetes tipo 2, poliuria, deshidratación profunda y alteración del estado mental. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Glucosa 980 mg/dL, osmolaridad efectiva alta, pH 7.35, cetonas mínimas y potasio 4.8 mEq/L. Tiene neumonía como precipitante y función cardíaca reducida conocida. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál componente terapéutico debe iniciarse primero y vigilarse estrechamente?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Reposición de volumen con cristaloideos isotónicos ajustada a estado hemodinámico, antes y durante insulinoterapia cuidadosamente dosificada. *
- C. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: El déficit de agua es extremo en estado hiperosmolar y la reanimación hídrica es inicial.

La caída rápida de osmolaridad puede causar complicaciones; potasio y glucosa se monitorizan antes de ajustar insulina.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de estado hiperosmolar hiperglucémico.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Hematología

Subtema: Leucemia aguda con leucostasis

Caso clínico 159. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 45 años con leucocitos 180,000/ μ L, disnea, cefalea, confusión y visión borrosa. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: Frotis muestra blastos; Hb 7.0 g/dL y plaquetas 24,000/ μ L. No hay sepsis, pero radiografía sugiere infiltrados bilaterales. Hematología se encuentra disponible. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál estrategia urgente es adecuada?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Leucorreducción con hidroxurea y/o leucaféresis según tipo y disponibilidad, soporte cuidadoso y tratamiento definitivo por hematología. *
- D. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.

Explicación: La leucostasis es emergencia por hiperviscosidad microvascular, frecuente con blastos altos. La transfusión de eritrocitos se valora con cuidado porque puede aumentar viscosidad; debe iniciarse citorreducción y prevenir lisis tumoral.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y tratamiento de leucemias agudas en el adulto.

Especialidad: Medicina Interna

Tema: Cardiología

Subtema: Endocarditis - profilaxis odontológica

Caso clínico 160. Una persona consulta en un contexto de segundo/tercer nivel de atención. Hombre de 40 años con válvula cardíaca protésica programado para extracción dental con manipulación gingival. Durante la valoración dirigida se documenta lo siguiente: No tiene infección activa, alergia a penicilina ni antibióticos recientes. Pregunta si requiere antibiótico porque un amigo con prolapso mitral lo recibió en el pasado. Se han descartado de forma inicial las contraindicaciones evidentes para la intervención urgente señalada cuando aplica. El caso se discute con el equipo tratante y se solicita seleccionar la conducta que mejor se apega a la guía mexicana indicada.

Pregunta: ¿Cuál indicación es correcta?

- A. Solicitar estudios adicionales de rutina y diferir toda intervención hasta contar con resultados completos.
- B. Iniciar un tratamiento sintomático aislado y egresar con vigilancia no estructurada.
- C. Aplicar una intervención alternativa que no aborda el mecanismo, gravedad o riesgo principal del caso.
- D. Administrar profilaxis antibiótica previa al procedimiento por ser portador de válvula protésica, conforme al esquema recomendado. *

Explicación: La profilaxis se reserva para pacientes de riesgo muy alto sometidos a procedimientos dentales que manipulan encía/periapical. No se indica para la mayoría de soplos o procedimientos no dentales sin infección.

Fuente: CENETEC/IMSS. Guía de Práctica Clínica: Prevención de endocarditis infecciosa.